

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi

ÉCOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE ÉCONOMIQUE

(ENSAE Pierre Ndiaye)

MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES

Pour l'obtention du diplôme d'Ingénieur Statisticien Économiste (ISE)

Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal

Présenté par :

Sié Rachid TRAORÉ
Élève Ingénieur Statisticien
Économiste

Sous la direction de :

Prénom NOM
Titre, Institution

Supervisé par :

Prénom NOM
Titre, Institution

Année académique 2025-2026

Dedicace

*À mes parents, Sié Kolotioloma TRAORE et Mariam COULIBALY,
pour leur amour sans faille, leur sacrifice et leur confiance inconditionnelle.*

*À mes frères et sœurs,
pour leur soutien constant tout au long de ce parcours.*

À tous ceux qui croient que l'éducation est la voie vers un avenir meilleur.

Remerciements

La réalisation de ce mémoire de fin d'études n'aurait pas été possible sans le concours de nombreuses personnes à qui je tiens à exprimer ma profonde gratitude.

Mes remerciements les plus sincères vont en premier lieu à mon directeur de mémoire, dont les orientations rigoureuses, la disponibilité et les conseils éclairés ont guidé chaque étape de ce travail. Sa rigueur scientifique et son exigence intellectuelle ont été pour moi une source d'émulation constante.

Je remercie également l'ensemble du corps enseignant de l'École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique (ENSAE Pierre Ndiaye) pour la qualité de la formation dispensée tout au long de ces années. Les enseignements reçus ont constitué le socle sur lequel repose la démarche méthodologique de cette étude.

Mes remerciements s'adressent aussi à l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) pour avoir mis à disposition les bases de données des Enquêtes Harmonisées sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM I et II), sans lesquelles ce travail empirique n'aurait pu être mené.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance à mes camarades de promotion pour les échanges fructueux, les moments de solidarité et l'ambiance de travail stimulante qui ont marqué ces années de formation à l'ENSAE.

Enfin, je rends hommage à ma famille, et plus particulièrement à mes parents, dont le soutien moral et les sacrifices consentis ont été le moteur de ma persévérance. Ce travail leur est dédié.

Que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'aboutissement de ce mémoire trouvent ici l'expression de ma sincère reconnaissance.

Résumé

Mots-clés : transferts de migrants, pauvreté multidimensionnelle des enfants, Sénégal, EHCVM, appariement par score de propension (PSM), double différence (DD).

(À compléter après l'obtention des résultats empiriques.)

Abstract

Keywords : remittances, child multidimensional poverty, Senegal, EHCVM, propensity score matching (PSM), difference-in-differences (DiD).

(To be completed after empirical results are obtained.)

Sommaire

Dedicace	i
Remerciements	ii
Résumé	iii
Abstract	iv
Liste des abréviations	viii
Introduction générale	1
1 Revue de la littérature	3
2 Données et méthodologie	12
3 Statistiques descriptives	22
4 Résultats des estimations	27
5 Discussion	32
Conclusion et recommandations	36
A Résultats complémentaires de l'appariement	38
B Méthodologie N-MODA Sénégal — Matrice des indicateurs	39
Table des matières	44

Table des figures

1	Évolution de l'indice N-MODA (H , A , M_0) entre EHCVM I et EHCVM II	25
2	Distribution du score de propension avant et après appariement (EHCVM I)	29
3	Impact des transferts de migrants par dimension N-MODA (ATT PSM-DD, IC 95 %)	31

Liste des tableaux

1	Répartition des ménages EHCVM II selon le statut de suivi (PanelHH)	13
2	Covariables du modèle de propension et sources EHCVM	15
3	Dimensions, indicateurs et seuils de privation – approche Alkire-Foster	16
4	Dimensions, indicateurs et seuils de privation – N-MODA Sénégal (ANSD/UNICEF 2024)	18
5	Caractéristiques des ménages — EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022)	23
6	Comparaison des ménages selon le statut de transferts (EHCVM I, 2018-2019)	24
7	Prévalence des privations par dimension N-MODA (enfants 0–17 ans) .	26
8	Taux de pauvreté N-MODA et intensité par groupe d’âge (EHCVM I, 2018-2019)	26
9	Modèle probit pour l’estimation du score de propension (EHCVM I, 2018-2019)	28
10	Équilibre des covariables avant et après appariement PSM ($k = 4$) . . .	29
11	Estimations par double différence (DD brute, sans appariement)	30
12	Impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle — estimateur PSM-DD (ATT)	30
13	Sensibilité de l’ATT PSM-DD au choix de la méthode d’appariement .	31
14	Sensibilité de l’ATT PSM-DD au seuil inter-dimensionnel k (indicateur AF)	32
15	Hétérogénéité des effets par milieu de résidence (PSM-DD)	34
16	Matrice N-MODA : indicateurs par dimension et groupe d’âge	40
17	Opérationnalisation des indicateurs N-MODA avec les variables EHCVM	42

Liste des abréviations

ANSD	Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
ATT	Average Treatment effect on the Treated (effet moyen sur les traités)
DD	Double Différence
DiD	Difference-in-Differences
EHCVM	Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages
ENSAE	École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique
ICT	Information and Communication Technology
IDH	Indice de Développement Humain
IPM	Indice de Pauvreté Multidimensionnelle
MPI	Multidimensional Poverty Index
OCDE	Organisation de Coopération et de Développement Économiques
ODD	Objectifs de Développement Durable
OPHI	Oxford Poverty and Human Development Initiative
PIB	Produit Intérieur Brut
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PSM	Propensity Score Matching
UEMOA	Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine

Introduction générale

Le Sénégal, à l'instar de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, se caractérise par une dépendance structurelle aux transferts de fonds envoyés par sa diaspora. Selon la Banque mondiale (**worldbank2023**), ces flux représentent entre 10 et 12% du produit intérieur brut sénégalais, dépassant largement les investissements directs étrangers et l'aide publique au développement. Cette réalité traduit l'ampleur des liens économiques qui unissent les ménages sénégalais à leurs membres établis à l'étranger – en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. La diaspora sénégalaise, estimée à plus de trois millions de personnes (**ndiaye2013**), constitue ainsi un acteur économique majeur dont les envois de fonds conditionnent le quotidien de plusieurs centaines de milliers de ménages.

Parallèlement, la pauvreté infantile demeure l'un des défis les plus pressants du développement sénégalais. Selon les résultats de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages de 2021-2022 (**ansd2022**), près de 37,5% de la population sénégalaise vit en dessous du seuil de pauvreté monétaire national, avec de fortes disparités entre milieux urbain et rural. Mais au-delà de la dimension monétaire, les enfants subissent des privations cumulées dans des domaines fondamentaux pour leur développement : l'accès à l'éducation, aux soins de santé, à l'eau potable et à l'assainissement. Ces privations multiples, qui échappent aux mesures traditionnelles basées sur le revenu ou la consommation, ont des conséquences durables sur le capital humain et les perspectives d'avenir des générations futures.

La question de l'impact des transferts de migrants sur le bien-être des enfants se situe à la jonction de ces deux réalités. Si plusieurs travaux ont documenté l'effet des remittances sur la scolarisation (**cox2003** ; **acosta2011**), la santé (**hildebrandt2005** ; **amuedo2007**) ou la consommation des ménages (**adams2005** ; **yang2008**), l'analyse de leur impact sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants – entendue comme la privation simultanée dans plusieurs dimensions du bien-être – reste insuffisamment explorée dans le contexte sénégalais. Cette lacune est d'autant plus notable que les bases de données disponibles offrent désormais des opportunités méthodologiques inédites pour aborder cette question de manière rigoureuse.

La principale difficulté méthodologique tient au biais de sélection : les ménages bénéficiaires de transferts diffèrent systématiquement des non-bénéficiaires sur des caractéristiques observables et inobservables, rendant toute comparaison naïve biaisée (voir section 1 pour une revue détaillée).

Pour surmonter cette difficulté, le présent travail combine deux méthodes d'évaluation d'impact : l'appariement par score de propension (PSM), introduit par **rosenbaum1983** et opérationnalisé par **heckman1997**, et la méthode de la double différence (DD). La disponibilité de deux vagues de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie

des Ménages – l'EHCVM I (2018-2019) et l'EHCVM II (2021-2022) – constitue une opportunité unique pour mettre en œuvre cette stratégie d'identification combinée. L'EHCVM II ayant suivi effectivement 86 % des ménages de la première vague (6 127 ménages identifiés par la variable `PanelHH`), il est possible d'observer les mêmes unités avant et après, ce qui renforce la crédibilité de l'hypothèse de tendances parallèles et permet de contrôler simultanément les biais de sélection observables et les effets fixes inobservables stables dans le temps.

Question de recherche. Dans quelle mesure les transferts de migrants réduisent-ils la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal ?

Objectif général. Ce mémoire vise à évaluer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal, à partir des données EHCVM I et II, en mobilisant une approche PSM combinée à la double différence.

Objectifs spécifiques :

1. Construire un Indice de Pauvreté Multidimensionnelle adapté aux enfants sénégalais (IPM-Enfant), en suivant l'approche d'Alkire-Foster ([alkire2011](#)), à partir des dimensions de l'éducation, de la santé et du niveau de vie ;
2. Analyser l'évolution de la pauvreté multidimensionnelle des enfants entre les deux vagues de l'EHCVM (2018-2019 et 2021-2022), en distinguant les milieux de résidence et les régions ;
3. Estimer l'effet causal des transferts de migrants sur l'IPM-Enfant à l'aide de l'estimateur PSM-Double différence, et analyser l'hétérogénéité des effets selon le milieu de résidence, le genre de l'enfant et la dimension de privation.

Hypothèses de recherche :

- H1 Les ménages bénéficiaires de transferts de migrants présentent une pauvreté multidimensionnelle des enfants significativement plus faible que les ménages non-bénéficiaires aux caractéristiques comparables.
- H2 L'effet des transferts est hétérogène selon les dimensions de la pauvreté et le milieu de résidence : il est plus marqué en milieu rural et davantage perceptible dans les dimensions éducation et santé.
- H3 La combinaison PSM-Double différence produit des estimations de l'effet causal moins biaisées que les approches naïves, en contrôlant à la fois la sélection observée et les facteurs inobservables stables dans le temps.

Ce mémoire s'articule en sept parties. La section 1 dresse une revue de la littérature sur les transferts de migrants, la pauvreté multidimensionnelle des enfants et les méthodes d'évaluation d'impact, en identifiant les lacunes auxquelles ce travail entend répondre. La section 2 présente les données EHCVM I et II ainsi que le cadre

méthodologique : construction de l'IPM-Enfant (Alkire-Foster et MODA), et stratégie d'identification PSM-Double différence. La section 3 expose les statistiques descriptives sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants et les caractéristiques des ménages bénéficiaires. La section 4 présente les résultats des estimations PSM-DD. La section 5 discute la robustesse des résultats et l'hétérogénéité des effets. La section 6 conclut et formule des recommandations de politique économique.

1 Revue de la littérature

Cette section passe en revue les travaux théoriques et empiriques pertinents pour notre problématique. Elle est organisée en deux parties complémentaires. La première partie établit le cadre conceptuel en examinant successivement la définition et les théories des transferts de migrants, les fondements de la mesure multidimensionnelle de la pauvreté des enfants, et les canaux par lesquels ces transferts peuvent réduire les privations infantiles. La seconde partie recense les résultats empiriques sur l'impact des transferts selon les différentes dimensions du bien-être de l'enfant, avant de dresser un bilan des lacunes méthodologiques que ce mémoire entend combler.

1.1 Revue théorique

Cette première partie établit les fondements théoriques de notre analyse. Elle présente d'abord les définitions et théories des transferts de migrants, puis le cadre conceptuel de la pauvreté multidimensionnelle des enfants, et enfin les canaux théoriques par lesquels ces transferts peuvent agir sur les différentes dimensions du bien-être infantile.

1.1.1 Les transferts de migrants : définitions, ampleur et théories

Cette sous-section définit les transferts de migrants et en présente l'ampleur mondiale et sénégalaise, avant d'exposer les principaux cadres théoriques qui expliquent les motivations à transférer.

Les transferts de fonds des migrants, communément appelés *remittances* dans la littérature anglophone, désignent les fonds envoyés par des personnes résidant à l'étranger vers leur pays ou leur région d'origine. Le Fonds Monétaire International distingue trois composantes principales : les transferts courants des travailleurs migrants, les rémunérations des salariés et les transferts de patrimoine des migrants. Dans la présente étude, nous retenons une définition large incluant l'ensemble des envois de fonds privés, formels et informels, destinés aux ménages bénéficiaires résidant au Sénégal.

La mesure des transferts se heurte à d'importantes limites statistiques. Les flux transitant par des canaux informels – réseaux de confiance, transport physique d'espèces – échappent aux statistiques officielles. Au Sénégal, selon **ocde2017**, les transferts

informels pourraient représenter entre 30 et 50% du total des flux reçus. Cette sous-estimation systématique doit être gardée à l'esprit lors de l'interprétation des résultats empiriques.

Les transferts de fonds constituent l'un des flux financiers les plus importants vers les pays en développement, surpassant depuis 2010 les flux d'aide publique au développement. À l'échelle mondiale, **worldbank2023** estimait ces flux à près de 794 milliards de dollars en 2022, dont 626 milliards à destination des pays à revenu faible et intermédiaire. Pour l'Afrique subsaharienne, ces flux atteignent environ 53 milliards de dollars en 2022, représentant en moyenne 3 à 5% du PIB régional, mais avec de fortes hétérogénéités nationales.

Le Sénégal figure parmi les pays d'Afrique de l'Ouest les plus dépendants de ces flux : les transferts y représentent structurellement 10 à 12 % du PIB, dépassant les IDE et l'aide publique au développement réunis (**worldbank2023**). La résilience de ces flux a été démontrée lors de la crise sanitaire : après une contraction de 1,6 % en 2020, ils ont rebondi de 11,8 % en 2021 (**worldbank2020**).

La littérature économique propose plusieurs cadres théoriques pour expliquer les motivations des migrants à envoyer des fonds.

Le modèle altruiste. La théorie la plus ancienne, formulée par **lucas1985**, postule que les migrants envoient des fonds par altruisme, c'est-à-dire par souci du bien-être des membres de leur famille restés au pays. Dans ce cadre, les transferts réagissent positivement au revenu du migrant et négativement au revenu du ménage bénéficiaire. Les transferts constituent ainsi un mécanisme de redistribution intrafamiliale.

La nouvelle économie des migrations. **stark1985** proposent une vision collective de la décision migratoire. La migration n'est pas le choix individuel d'un acteur rationnel maximisant son utilité espérée, mais une décision collective du ménage visant à diversifier ses sources de revenus et à se prémunir contre les chocs. Les transferts sont le produit d'un arrangement implicite entre le migrant et sa famille, rationalisant un investissement commun dans la migration.

L'échange et le remboursement. **rapoport2006** recensent un troisième mobile, celui du remboursement d'une dette implicite. Le ménage a financé la migration (éducation, coût du voyage, soutien initial), et les transferts constituent la contrepartie de cet investissement. Cette logique prédit que les transferts diminuent au fil du temps, à mesure que la dette est apurée.

Le précautionnement et l'assurance. **gubert2002**, dans une étude pionnière conduite auprès des ménages maliens, montre que les transferts jouent un rôle d'assurance informelle : ils augmentent en période de choc négatif affectant le ménage d'origine, suggérant que le migrant agit comme un assureur résiduel pour les siens. Ce résultat est cohérent avec le cadre théorique de l'aversion au risque et a été confirmé dans le contexte sénégalais par plusieurs travaux ultérieurs, notamment **fall2010** qui montre

que les ménages dans les zones à forte émigration lisent mieux les chocs pluviométriques grâce aux transferts.

L'investissement stratégique. Une quatrième théorie, moins explorée mais pertinente pour le Sénégal, analyse les transferts comme instrument d'investissement collectif dans le capital social et physique. Les associations de migrants (tontines, fonds villageois) organisent des transferts collectifs destinés au financement d'infrastructures locales (puits, mosquées, écoles). Ce canal collectif, documenté par **azam2016** pour l'Afrique de l'Ouest, peut avoir des effets diffus sur l'ensemble des ménages d'une communauté, y compris ceux qui ne reçoivent pas de transferts directs.

En pratique, ces motivations se combinent et varient selon les caractéristiques des ménages et des migrants. **azam2016**, dans une revue de la littérature africaine, montrent que l'altruisme et l'assurance dominent parmi les mobiles identifiés, et que les effets sur le bien-être sont globalement positifs, quoique très hétérogènes selon le niveau de revenu initial du ménage, la destination du migrant et la régularité des envois.

1.1.2 Pauvreté multidimensionnelle : cadre conceptuel

Après avoir présenté les limites de l'approche monétaire traditionnelle, cette sous-section expose les deux cadres de mesure retenus dans ce mémoire : l'approche Alkire-Foster et la méthode MODA développée par l'UNICEF, avant de situer la pauvreté multidimensionnelle des enfants dans le contexte sénégalais.

La conception dominante de la pauvreté, fondée sur le revenu ou la consommation par habitant, présente plusieurs limites importantes pour l'analyse du bien-être des enfants. Premièrement, le seuil monétaire ne capture pas l'accès aux services publics (éducation, santé, eau potable, assainissement) qui conditionnent fondamentalement le développement de l'enfant. Deuxièmement, la dimension intra-ménage de la répartition des ressources est ignorée : un ménage non pauvre peut abriter des enfants privés de soins essentiels. Troisièmement, les besoins spécifiques des enfants – nutrition, stimulation cognitive, protection – ne sont pas reflétables par un indicateur monétaire agrégat (**gordon2003**).

sen1999 a formulé le cadre théorique des “capabilités” qui fonde l'approche multidimensionnelle. Selon cet auteur, la pauvreté doit être comprise comme une privation de libertés et de capacités fondamentales, et non comme le seul manque de ressources monétaires. Cette perspective a été opérationnalisée par **townsend1979** qui introduit la notion de privation relative et absolue, et plus tard par **unicef2007** dans le cadre de la mesure de la pauvreté infantile.

alkire2011 ont développé une famille de mesures de pauvreté multidimensionnelle qui constitue le fondement méthodologique de l'Indice de Pauvreté Multidimensionnelle (IPM) utilisé par le Programme des Nations Unies pour le Développement depuis 2010 (**pnud2010**). Cette approche présente deux innovations majeures par rapport aux

mesures existantes.

La première innovation est le double seuil d'identification. Un individu est identifié comme privé dans une dimension j si son niveau de réalisation est inférieur au seuil de privation z_j propre à cette dimension. Il est ensuite identifié comme multidimensionnellement pauvre si le nombre pondéré de ses privations dépasse un seuil inter-dimensionnel k . Ce double seuil permet de distinguer les individus qui cumulent les privations – les plus vulnérables – de ceux qui n'en subissent qu'une ou deux.

La seconde innovation est la décomposabilité de la mesure. L'IPM $M_0 = H \times A$ peut être décomposé par groupe de population, par dimension et par région, ce qui en fait un outil utile pour l'analyse des politiques publiques ciblées.

Cette approche a été appliquée à de nombreux contextes africains (**battiston2013** ; **ferreira2011**) et au Sénégal en particulier (**ba2017** ; **ansd2022**). Les résultats pour le Sénégal montrent une pauvreté multidimensionnelle significativement plus élevée que la pauvreté monétaire, en particulier dans les dimensions de l'assainissement, de l'accès à l'eau et de l'éducation en milieu rural.

Si l'approche Alkire-Foster constitue la référence méthodologique dominante pour la mesure de la pauvreté multidimensionnelle des adultes et des ménages, elle présente des limites spécifiques lorsqu'elle est appliquée aux enfants. En particulier, elle utilise les mêmes indicateurs et les mêmes seuils quel que soit l'âge de l'enfant, alors que les besoins fondamentaux diffèrent substantiellement entre un nourrisson et un adolescent. Elle hérite par ailleurs de la tradition centrée sur le ménage et ne reflète pas directement les privations de l'enfant individuel (**roelen2008**).

C'est en réponse à ces limites que l'UNICEF a développé la méthode MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis). **deneubourg2012** en ont formalisé le cadre méthodologique et ses fondements théoriques. L'approche MODA se distingue sur trois points fondamentaux. Premièrement, l'enfant est l'unité d'analyse, et non le ménage : les privations sont mesurées directement au niveau de l'individu. Deuxièmement, les indicateurs de privation sont désagrégés par groupe d'âge, de sorte que les dimensions pertinentes pour un enfant de 2 ans (nutrition, vaccination) diffèrent de celles d'un enfant de 12 ans (scolarisation, accès à l'information). Troisièmement, plutôt que d'agréger les privations en un indice composite unique, MODA s'intéresse à la structure des *privations superposées* : quelles dimensions se cumulent chez les enfants les plus vulnérables, et dans quelles proportions.

demilliano2014 ont appliqué cette méthodologie à l'Afrique subsaharienne et montré que les configurations de privations des enfants varient considérablement selon le groupe d'âge et le pays, justifiant l'approche désagrégée de MODA. En Afrique de l'Ouest, les privations les plus fréquentes chez les jeunes enfants (0-4 ans) sont l'accès à l'eau potable et l'assainissement, tandis que pour les enfants d'âge scolaire (5-14 ans), la non-scolarisation et le retard scolaire occupent une place centrale.

La spécificité de la pauvreté infantile a été reconnue très tôt dans la littérature (**townsend1979** ; **gordon2003**). Les enfants sont doublement vulnérables : d’une part, ils dépendent entièrement des adultes pour accéder aux ressources ; d’autre part, les privations subies pendant l’enfance ont des effets durables sur le développement cognitif, la santé et les trajectoires éducatives et professionnelles futures. **unicef2007** a impulsé le programme mondial d’étude de la pauvreté infantile, qui a inspiré de nombreux travaux empiriques dans les pays en développement.

Dans le contexte sénégalais, la première analyse nationale de grande envergure s’appuyait sur l’ESPS-II de 2011 (**ba2017**). La plus récente – et la plus détaillée – est celle conduite par **ansd2024** à partir de l’EHCVM 2018/19, en utilisant la méthode N-MODA adaptée au contexte sénégalais lors d’un atelier participatif regroupant l’ANSD et les ministères sectoriels. Avec un seuil $k = 4$ dimensions simultanées (sur 7), 50,7% des enfants âgés de 0 à 17 ans sont multidimensionnellement pauvres (H), avec une intensité moyenne de 72,2% (A) et un indice ajusté $M_0 = 0,366$. La prévalence est nettement plus élevée en milieu rural (66,5%) qu’urbain (28,1%), et atteint 82,1% dans la région de Kédougou, 79,4% à Kolda et 78,0% à Sédhiou. En parallèle, 43,3% des enfants vivent dans des ménages monétairement pauvres (seuil national : 333 440 FCFA/personne/an) et 97,9% souffrent d’au moins une privation dans l’une des sept dimensions de bien-être retenues.

1.1.3 Canaux d’impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants

Cette sous-section fait le lien entre la théorie et l’analyse empirique en identifiant, dimension par dimension, les mécanismes par lesquels les transferts de migrants peuvent réduire la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Ces canaux guident la construction des variables de résultat et l’interprétation des estimations présentées aux sections suivantes.

La théorie des capacités et les travaux empiriques permettent d’identifier six canaux principaux par lesquels les transferts de migrants agissent sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants.

En matière d’éducation, les transferts lèvent la contrainte de liquidité qui empêche les ménages pauvres d’investir dans la scolarisation : ils financent les frais de scolarité, les uniformes et les fournitures, tout en réduisant le recours au travail des enfants (**cox2003** ; **acosta2011**), conformément au modèle altruiste de transfert (**lucas1985**).

Sur le plan sanitaire, l’accroissement du revenu disponible permet aux ménages bénéficiaires d’accéder aux consultations médicales, aux médicaments et à la vaccination, et d’améliorer la nutrition des enfants par une consommation plus diversifiée (**hildebrandt2005** ; **amuedo2007**).

Au-delà du canal sanitaire, les transferts modifient directement la structure de

consommation alimentaire, en augmentant les dépenses en aliments diversifiés et en améliorant le suivi de la croissance des jeunes enfants (**calero2009**).

S'agissant de l'accès à l'eau, une partie des fonds reçus est affectée à des investissements dans le logement, notamment au raccordement au réseau d'eau ou à l'acquisition d'équipements de stockage améliorés (**yang2008** ; **gubert2002**).

Pour l'assainissement, les transferts financent la construction ou l'amélioration des toilettes et latrines, permettant d'accéder à des infrastructures sanitaires conformes aux normes JMP (**azam2016** ; **combes2019**).

Enfin, motivés par un souci d'assurance et de prestige social (**gubert2002** ; **stark1985**), les ménages bénéficiaires investissent dans la rénovation des matériaux de construction et l'agrandissement du logement, réduisant le surpeuplement.

Ces canaux ne sont pas mutuellement exclusifs : un ménage bénéficiaire peut simultanément améliorer son alimentation, rénover son logement et financer la scolarisation de ses enfants. L'intensité relative de chaque canal dépend du montant, de la régularité des transferts et du contexte socio-économique du ménage. L'approche multidimensionnelle adoptée dans ce mémoire permet précisément de capturer l'ensemble de ces effets et d'évaluer leur ampleur relative.

1.2 Revue empirique

Cette seconde partie recense les résultats empiriques de la littérature sur l'impact des transferts de migrants sur le bien-être des enfants. Elle examine successivement les effets documentés sur chaque grande dimension de la pauvreté multidimensionnelle — pauvreté monétaire, éducation, santé, logement — avant de dresser un bilan des travaux portant directement sur la pauvreté multidimensionnelle et d'identifier les lacunes que ce mémoire cherche à combler.

1.2.1 Impact des transferts sur le bien-être des ménages

Cette sous-section passe en revue les travaux empiriques sur l'effet des transferts sur les différentes composantes du bien-être des enfants : pauvreté monétaire des ménages, scolarisation, santé et conditions de logement.

La relation entre transferts de migrants et réduction de la pauvreté monétaire est l'une des plus documentées dans la littérature du développement. **adams2005**, à partir d'un échantillon de 71 pays en développement, trouvent qu'une augmentation de 10% de la part des transferts dans le PIB est associée à une baisse de 3,5% de la proportion de personnes vivant avec moins d'un dollar par jour. **acosta2008**, pour l'Amérique latine, confirment un effet réducteur de la pauvreté monétaire, bien que l'effet sur les inégalités soit ambigu en raison de la sélection positive des migrants.

Ces résultats globaux masquent une hétérogénéité considérable. **taylor2008** montrent

pour le Mexique que les transferts réduisent la pauvreté dans les zones à forte émigration mais peuvent accroître les inégalités si les ménages aisants sont sur-représentés parmi les familles de migrants. Dans le contexte africain, **azam2016** concluent à un effet positif mais modeste sur la pauvreté monétaire, fortement atténué par les coûts de transaction élevés des transferts formels et la dépendance aux canaux informels.

Pour l’Afrique de l’Ouest spécifiquement, les résultats sont contrastés. **combes2019** montrent, à partir de données de panel couvrant plusieurs pays de l’UEMOA, que les transferts réduisent la volatilité de la consommation des ménages et ont un effet réducteur sur la pauvreté transitoire, mais un effet plus faible sur la pauvreté chronique. Au Sénégal, les rares études disponibles (**fall2010**) suggèrent que les ménages bénéficiaires ont une consommation par tête supérieure de 15 à 25% à celle des non-bénéficiaires, mais que cet écart est partiellement expliqué par des caractéristiques non observables des ménages migrants.

La littérature empirique sur l’effet des transferts sur la scolarisation des enfants est abondante mais révèle des résultats contrastés. **cox2003**, dans une étude portant sur le Salvador, montrent qu’un accroissement des transferts reçus réduit significativement la probabilité d’abandon scolaire, avec des effets plus marqués pour les enfants du secondaire. L’effet passe par la levée de la contrainte de liquidité, qui empêche les ménages pauvres d’investir dans l’éducation de leurs enfants même lorsque les rendements privés sont positifs.

acosta2011 confirment ces résultats pour le même pays et montrent que les transferts permettent également de réduire le travail des enfants, libérant du temps pour la fréquentation scolaire. Pour les Philippines, **yang2008** exploite les chocs sur les taux de change comme variation exogène des transferts et trouve un effet positif et significatif sur la fréquentation scolaire, particulièrement pour les enfants issus des ménages les plus pauvres.

En Afrique subsaharienne, **gyimah2013** trouvent, pour le Ghana, que les ménages bénéficiaires de transferts ont des enfants avec des taux de scolarisation au primaire plus élevés, et que cet effet est plus prononcé en milieu rural. En revanche, pour l’Afrique de l’Ouest, **azam2016** signalent que l’effet positif sur la scolarisation est souvent conditionnel à l’existence d’écoles accessibles et de qualité, ce qui n’est pas toujours garanti dans les zones rurales éloignées. Dans le cas sénégalais, la coexistence de l’école publique et des *daara* (écoles coraniques) complexifie l’interprétation des indicateurs de scolarisation : un enfant non-scolarisé au sens formel peut être effectivement instruit dans une structure informelle (**unicef2016**).

Les résultats sont moins univoques pour l’Afrique francophone. **mansuri2006** trouve, pour le Pakistan, que la migration du père peut paradoxalement réduire la scolarisation des enfants, notamment des filles, en l’absence du tuteur principal du ménage. Cet effet d’“absentéisme parental” est potentiellement important dans le contexte sénégalais où

la migration masculine est dominante et où la supervision parentale joue un rôle clé dans la décision de scolarisation des filles.

hildebrandt2005 ont été parmi les premiers à documenter l'effet des transferts sur la santé infantile, en utilisant les données mexicaines. Leurs résultats indiquent que les enfants des ménages bénéficiaires de transferts présentent une mortalité infantile plus faible, un poids à la naissance plus élevé et une meilleure couverture vaccinale. Ces effets passent principalement par l'augmentation des dépenses de santé et l'amélioration des conditions de logement.

amuedo2007 confirment, également pour le Mexique, que les transferts accroissent significativement les dépenses de santé préventive des ménages. Ils montrent que cet effet est plus fort pour les ménages ruraux et les ménages à faibles revenus initiaux. **antman2012** nuance ces résultats en signalant que l'absence du parent migrant peut avoir des effets négatifs sur la santé mentale des enfants, en raison d'un manque de supervision et de soutien émotionnel.

calero2009 étudient le cas équatorien et trouvent que les transferts augmentent les dépenses de santé, tout en réduisant la probabilité que les enfants souffrent de retard de croissance. Ces effets sont conditionnels à l'existence de services de santé accessibles, ce qui soulève la question de la complémentarité entre les transferts privés et les investissements publics en infrastructure.

Au-delà de l'éducation et de la santé, les transferts influencent les conditions de logement et d'accès aux services de base, qui constituent des dimensions importantes de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. **yang2008** montre que les transferts accroissent significativement les dépenses de rénovation du logement au sein des ménages philippins. **combes2019** trouvent que les transferts stabilisent la consommation des ménages en période de choc, ce qui bénéficie indirectement aux enfants en maintenant un niveau minimal d'accès aux biens essentiels.

Dans le contexte africain, plusieurs travaux ont montré que les transferts sont fréquemment utilisés pour améliorer les conditions de logement (construction, rénovation) et accéder à l'eau potable et à l'assainissement (**gubert2002** ; **azam2016**). Ces investissements peuvent avoir un impact direct sur les dimensions non-éducatives et non-sanitaires de la pauvreté multidimensionnelle des enfants.

1.2.2 Transferts et pauvreté multidimensionnelle : bilan et lacunes

Cette sous-section clôt la revue empirique en recensant les rares travaux qui analysent l'impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle dans son ensemble, en discutant les stratégies d'identification causale disponibles, et en précisant la contribution originale de ce mémoire.

Les travaux qui analysent directement l'impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle – et non sur ses composantes prises isolément – restent rares. **acosta2008**

construisent un indicateur composite pour l'Amérique latine et trouvent un effet négatif des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle, mais leurs résultats souffrent de l'endogénéité des transferts. **mckenzie2012** passent en revue les défis méthodologiques posés par cette littérature et concluent que la plupart des estimations sont biaisées à la hausse en raison de la sélection des ménages migrants.

La principale difficulté méthodologique de cette littérature tient au biais de sélection : les ménages qui reçoivent des transferts diffèrent systématiquement des ménages non-bénéficiaires, en termes de caractéristiques observables (niveau d'éducation, localisation, accès au crédit) et inobservables (réseaux sociaux, propension à migrer, qualité des liens familiaux, aversion au risque). Une estimation naïve de l'effet des transferts sur la pauvreté infantile est donc biaisée à la fois par la sélection positive (migrants plus éduqués) et la sélection négative (familles envoyant le migrant le plus apte).

Plusieurs stratégies d'identification ont été utilisées dans la littérature. La variable instrumentale est la plus robuste théoriquement : **yang2008** exploite les chocs exogènes sur les taux de change, et **acosta2011** utilisent la densité historique des réseaux de migrants comme instrument. Ces stratégies, bien qu'efficaces, requièrent des instruments crédibles qui ne sont pas facilement disponibles dans le contexte sénégalais.

La régression sur discontinuité a été utilisée par certains travaux exploitant des seuils réglementaires d'accès aux transferts ou de droit à la migration (**mckenzie2012**), mais son application reste limitée à des contextes spécifiques.

L'appariement par score de propension (PSM), introduit par **rosenbaum1983** et développé par **heckman1997**, constitue une alternative crédible lorsque des instruments exogènes valides ne sont pas disponibles. Le PSM permet de contrôler les différences observables entre bénéficiaires et non-bénéficiaires, en construisant un groupe de comparaison statistiquement comparable au groupe traité sous l'hypothèse d'indépendance conditionnelle. **caliendo2008** offrent un guide méthodologique complet pour sa mise en œuvre et le test de la qualité de l'appariement.

L'estimateur PSM-DD combine ces deux approches : le PSM corrige le biais de sélection sur les observables, tandis que la double différence (DD) neutralise les effets fixes inobservables stables dans le temps (**heckman1998** ; **smith2005**). Cette approche combinée a été utilisée avec succès dans l'évaluation de politiques sociales en Afrique (**card1994** ; **angrist2009**) — notamment dans les programmes conditionnels de transferts monétaires — mais reste peu exploitée dans la littérature sur les remittances privés en Afrique subsaharienne.

La revue de la littérature met en évidence plusieurs lacunes importantes que ce mémoire entend combler.

Premièrement, la pauvreté multidimensionnelle des enfants est rarement l'objet direct de l'analyse dans les travaux sur les transferts : la plupart des études se concentrent sur une dimension isolée (scolarisation, mortalité infantile, dépenses de santé). Or, les

enfants subissent des privations simultanées dans plusieurs dimensions, et l’effet des transferts sur ces privations peut être très hétérogène.

Deuxièmement, très peu de travaux portent sur le Sénégal spécifiquement, alors que ce pays présente des caractéristiques remarquables : un niveau de dépendance aux transferts parmi les plus élevés d’Afrique subsaharienne, une diaspora ancienne et géographiquement diversifiée, et une pauvreté infantile encore très élevée malgré une croissance économique soutenue.

Troisièmement, la combinaison PSM et double différence sur des données de panel – qui permet de contrôler simultanément les biais de sélection observables et les effets fixes inobservables – n’a pas, à notre connaissance, été appliquée à cette question dans le contexte sénégalais. L’existence de deux vagues de l’EHCVM (2018-2019 et 2021-2022) offre une opportunité inédite pour mettre en œuvre cette stratégie.

Ce mémoire contribue donc à la littérature sur au moins trois points : (i) il construit et analyse un indice de pauvreté multidimensionnelle spécifiquement adapté aux enfants sénégalais ; (ii) il exploite la dimension panel des données EHCVM I et II pour identifier un effet causal crédible ; (iii) il analyse l’hétérogénéité des effets selon le milieu de résidence, le genre et les dimensions de la pauvreté.

2 Données et méthodologie

Cette section présente l’architecture méthodologique de la recherche. La mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants mobilise deux approches complémentaires : l’approche Alkire-Foster, qui fournit un indice synthétique agrégeable et décomposable (IPM-Enfant), et l’approche MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis) de l’UNICEF, qui analyse les privations superposées en distinguant les groupes d’âge. Ces deux mesures constituent les variables de résultat de la stratégie d’identification causale fondée sur la combinaison du score de propension (PSM) et de la double différence (DD), mise en œuvre sur les deux vagues de l’Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM I et II).

2.1 Données : les enquêtes EHCVM I et II

2.1.1 Présentation des enquêtes

Les Enquêtes Harmonisées sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM) sont réalisées dans le cadre du programme statistique de l’UEMOA. EHCVM I (2018-2019) est la première vague nationale au Sénégal (**ansd2019**), reposant sur un plan de sondage stratifié à deux degrés (régions $\times$ milieux comme strates, zones de dénombremments comme unités primaires). EHCVM II (2021-2022) reproduit le même protocole en suivant effectivement une large partie des ménages enquêtés en 2018-2019 (**ansd2022**) :

la variable **PanelHH** identifie 6 127 ménages retrouvés dans les deux vagues, soit 86 % de l'échantillon de 2021. La fenêtre temporelle 2018-2022 couvre une période de transformations importantes des flux migratoires sénégalais et de leurs effets sur les ménages.

2.1.2 Construction de l'échantillon

Notre population cible est l'ensemble des enfants âgés de 0 à 17 ans résidant dans les ménages enquêtés dans les deux vagues. L'EHCVM I couvre 7 120 ménages (vagues 1 et 2 réunies), et l'EHCVM II 7 120 ménages selon le même plan de sondage, avec un sous-échantillon panel identifié par la variable **PanelHH** (**ansd2019** ; **ansd2022**).

L'échantillon analytique repose sur le **panel vrai** constitué des 6 127 ménages identifiés par **PanelHH** = 1, c'est-à-dire les ménages enquêtés lors des deux vagues et retrouvés dans leur logement d'origine (variable **s00q07e** : 5 643 ménages dans le même logement ; 290 ménages retrouvés dans un nouveau logement). Chaque ménage est ainsi observé en $t = 0$ (2018-2019) et $t = 1$ (2021-2022), ce qui autorise une estimation DD en différences intra-ménage sans recourir à des hypothèses d'agrégation au niveau des grappes (**deaton1997**).

Le tableau 1 présente la répartition des ménages enquêtés en 2021-2022 selon leur statut de suivi et le milieu de résidence.

Table 1. Répartition des ménages EHCVM II selon le statut de suivi (**PanelHH**)

	Nouveau ménage		Ménage panel		Total
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	<i>n</i>
Urbain	740	18,9	3 182	81,1	3 922
Rural	253	7,9	2 945	92,1	3 198
Total	993	13,9	6 127	86,1	7 120
<i>Dont ménages panel selon condition de logement</i>					
Même logement qu'en 2018			5 643	92,1	
Logement différent			290	4,7	
Non renseigné			194	3,2	

Source : EHCVM II (2021-2022), module **s00_me_sen2021**, variable **PanelHH** (*Type de ménage*) et **s00q07e** (*Le ménage occupait-il le même logement lors de l'enquête de 2018/19 ?*).

Note : Le milieu urbain présente un taux d'attrition plus élevé (18,9 %) que le milieu rural (7,9 %), reflétant une plus grande mobilité résidentielle en zone urbaine.

Après nettoyage (exclusion des observations avec plus de deux indicateurs de privation manquants et des ménages sans information sur les transferts), l'échantillon retenu comprend les enfants âgés de 0 à 17 ans pour lesquels l'intégralité des indicateurs AF et MODA ainsi que la variable de traitement sont disponibles dans les deux vagues.

L'échantillon complet incluant les 993 nouveaux ménages de 2021 (`PanelHH = 0`) est utilisé dans les analyses de robustesse. La limite principale de cette construction est l'attrition différentielle : si les ménages perdus entre les deux vagues diffèrent systématiquement des ménages retenus, les estimations PSM-DD peuvent être biaisées – ce point est discuté dans la section 5.

2.1.3 Variable de traitement

La variable de traitement $D_i \in \{0, 1\}$ est un indicateur statique, figé sur la période de base (2018), qui indique si le ménage de l'enfant i a reçu des transferts d'un membre émigré à l'étranger au cours des 12 mois précédant l'enquête de 2018 et n'en a pas reçu en 2021. Cette définition en deux temps garantit la stabilité du statut de traitement entre les deux vagues et est conforme aux conventions de la littérature empirique sur les remittances en Afrique ([azam2016](#) ; [combes2019](#)).

La construction de cette variable repose sur les modules de transferts des deux vagues EHCVM. Dans chaque vague, deux fichiers sont mobilisés : `s13a_1` (identification des ménages ayant reçu au moins un transfert) et `s13a_2` (caractéristiques de chaque transfert et de son expéditeur). Un ménage est classé comme bénéficiaire ($D_i = 1$) s'il satisfait les deux conditions suivantes : (i) il a reçu en 2018 au moins un transfert dont l'expéditeur est localisé hors du Sénégal (code ≥ 4 pour la variable `s13aq14` en 2018 ; codes 1 à 3 correspondant à des destinations intérieures) ; (ii) il n'a pas reçu de tel transfert en 2021. Le groupe témoin ($D_i = 0$) est composé de ménages n'ayant reçu aucun transfert international ni en 2018 ni en 2021 (*never treated*). Cette restriction élimine les ménages dont le statut change entre les deux vagues (entrants tardifs), dont l'inclusion biaiserait l'estimateur de la double différence ([callaway2021](#)). Les transferts internes (interrégionaux, codes 1 à 3) sont exclus dans les deux vagues car ils relèvent d'une logique de redistribution domestique distincte des envois de la diaspora internationale ([ndiaye2013](#)).

2.1.4 Covariables du modèle de propension

Le modèle probit estime la probabilité qu'un ménage reçoive des transferts en fonction de ses caractéristiques pré-transfert observées. Les covariables sont choisies pour satisfaire l'hypothèse d'indépendance conditionnelle (CIA) tout en évitant d'inclure des variables potentiellement affectées par le traitement.

Table 2. Covariables du modèle de propension et sources EHCVM

Groupe	Variable	Variable EHCVM
Chef de ménage	Âge du CM	hage
	Sexe (féminin = 1)	hgender
	Niveau d'éducation	heduc
	Statut matrimonial	hmstat
Composition	Taille du ménage	hhsiz
	Bien-être initial	pcexp
Localisation	Milieu (urbain = 1)	milieu
	Région (14 régions)	region

Note : CM = chef de ménage. **pcexp** est transformée en logarithme ($\log_pcexp$) pour réduire l'asymétrie de la distribution. **region** est traitée comme un facteur à 14 modalités. La spécification finale est : $D \sim hhsiz + \log(pcexp) + milieu + region + hgender + hage + heduc + hmstat$.

2.2 Mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants

2.2.1 Fondements conceptuels

Les mesures monétaires de la pauvreté ne rendent pas compte des conditions de vie des enfants pour deux raisons fondamentales. D'une part, elles supposent une distribution intrafamiliale équitable des ressources, ce que les données infirment généralement (**deaton1997**). D'autre part, elles ignorent des dimensions non monétaires – éducation, santé, eau, assainissement, information – irréductibles au revenu du ménage et déterminantes pour le développement de l'enfant (**gordon2003** ; **sen1999**). L'approche par les capacités de **sen1985** fournit le socle conceptuel : ce qui importe n'est pas seulement les ressources mais la capacité effective de l'enfant à fonctionner dans chaque dimension fondamentale de son développement.

Dans ce cadre, deux méthodes de mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants sont adoptées, chacune apportant une information complémentaire sur les privations subies.

2.2.2 Première approche : l'indice Alkire-Foster (IPM-Enfant)

La méthode d'Alkire-Foster (**alkire2007** ; **alkire2011**) construit un indice synthétique de pauvreté multidimensionnelle en deux étapes. Soit n enfants, $d = 6$ indicateurs répartis en trois dimensions (éducation, santé, niveau de vie) et y_{ij} la valeur de l'indica-

teur j pour l'enfant i . La variable de privation élémentaire est :

$$g_{ij} = \mathbf{1}[y_{ij} < z_j] \quad (1)$$

où z_j est le seuil de privation de la dimension j .

Le score de privation pondéré de l'enfant i est :

$$c_i = \sum_{j=1}^d w_j g_{ij} \quad (2)$$

avec des poids égaux $w_j = 1/6$. Un enfant est identifié comme multidimensionnellement pauvre si $c_i \geq k$, avec $k = 1/3$ (au moins deux indicateurs sur six).

L'IPM-Enfant est ensuite calculé comme le produit de l'incidence H et de l'intensité moyenne A :

$$M_0 = H \times A \quad (3)$$

où $H = q/n$ est la proportion d'enfants pauvres et $A = \frac{1}{q} \sum_{i: c_i \geq k} c_i$ l'intensité moyenne des privations parmi les pauvres. La mesure M_0 est décomposable par groupe de population et par dimension, ce qui permet d'analyser la contribution de chaque région, milieu et dimension à la pauvreté globale.

Table 3. Dimensions, indicateurs et seuils de privation – approche Alkire-Foster

Dimension	Indicateur	Seuil de privation	Poids
Éducation	Fréquentation scolaire	Enfant de 6 à 17 ans non scolarisé	1/6
	Retard scolaire	Retard supérieur ou égal à 2 ans	1/6
Santé	Suivi nutritionnel	Aucune consultation dans les 12 mois	1/6
	Vaccination	Vaccination incomplète (0-5 ans)	1/6
Niveau de vie	Accès à l'eau	Source d'eau non améliorée (normes JMP)	1/6
	Assainissement	Toilettes non améliorées (normes JMP)	1/6

Note : Normes JMP : Joint Monitoring Programme OMS/UNICEF. Seuil inter-dimensionnel $k = 1/3$. Poids égaux $w_j = 1/6$.

2.2.3 Deuxième approche : MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis)

L'approche MODA, développée par **deneubourg2012** au sein du bureau de recherche de l'UNICEF et appliquée en Afrique subsaharienne par **demilliano2014**, part du constat que l'approche Alkire-Foster présente deux limites lorsqu'elle est appliquée aux enfants. D'abord, elle utilise les mêmes indicateurs et seuils quel que soit l'âge, alors que les besoins fondamentaux varient considérablement entre un nourrisson et un adolescent. Ensuite, les poids et le seuil inter-dimensionnel sont fixés de manière normative plutôt que dérivés des configurations de privations effectives.

MODA répond à ces limites selon trois principes. Premièrement, l'enfant individuel – et non le ménage – est l'unité d'analyse. Deuxièmement, les indicateurs sont désagrégés par groupe d'âge pour refléter les droits spécifiques à chaque stade de développement. Troisièmement, l'analyse porte sur les *privations superposées* (overlapping deprivations) : quelles privations se combinent chez les enfants les plus vulnérables, et avec quelle intensité.

MODA est ainsi complémentaire à Alkire-Foster : là où AF fournit un indice synthétique agrégeable, MODA fournit une analyse fine de la structure des privations par âge et de leurs combinaisons. Dans notre étude, les deux mesures constituent des variables de résultat alternatives pour l'estimation PSM-DD, permettant de vérifier la robustesse des conclusions.

Suivant **deneubourg2012** et l'adaptation nationale N-MODA développée pour le Sénégal lors d'un atelier participatif rassemblant l'ANSD et les ministères sectoriels (**ansd2024**), nous distinguons trois groupes d'âge avec des indicateurs adaptés aux droits spécifiques de chaque phase de l'enfance. Le tableau 4 présente les dimensions et indicateurs retenus, en cohérence avec l'EHCVM et la méthodologie N-MODA.

Table 4. Dimensions, indicateurs et seuils de privation – N-MODA Sénégal (ANSD/UNICEF 2024)

Dimension	Indicateurs de privation	Seuil / Définition	Variables EHCVM
Assainissement	Toilettes non améliorées	Sanitaires non conformes normes JMP	toilet
	Partage des toilettes	Installation partagée entre ménages	partag_toi
Eau	Source non améliorée	Codes non-JMP (sèche ou pluies)	eauboi_ss/sp
	Temps d'accès > 30 min	Saison sèche ou pluies	tps_eau_ss/sp
Logement	Gestion des ordures inadéquate	Brûlée, dépôt sauvage ou autre	ordure
	Surpeuplement > 3 pers./pièce	Rapport personnes/pièces	nbpiec
Nutrition	Diversité des repas (5–17 ans)	≥ 1 macro-groupe non consommé quotidiennement (7j/7)	s08b02a-j [†]
	Sécurité alimentaire (0–17 ans)	Saut repas, mangé moins, faim ou journée sans manger	s08aq04–08
Santé	Combustible solide	Bois, charbon ou déchets pour cuisiner	combust
	Accès aux soins	Pas d'accès à pied à une structure	n.d. [†]
Protection de l'enfant	Absence d'acte de naissance	0–14 ans : acte_nais = 0	acte_nais
	Travail des enfants	5–14 ans : activ7j $\in \{1, 2\}$	activ7j
	Séparation parentale	Ne vit pas avec 2 parents biologiques	lien
Éducation	Non-scolarisation	5–14 ans : scol = 0	scol
	Illettrisme	15–17 ans : pas de lecture/écriture	alfab
	NEET	15–17 ans : ni étude, ni emploi	scol, activ7j

Source : ansd2024. Méthodologie N-MODA Sénégal (National Multiple Overlapping Deprivation Analysis). *Approche union* intra-dimension : un enfant est privé dans une dimension s'il l'est dans *au moins un* de ses indicateurs. *Seuil inter-dimensionnel* : $k = 4$ (enfant multidimensionnellement pauvre si privé dans au moins 4 dimensions sur 7 simultanément). $H = 50,7\%$, $A = 72,2\%$, $M_0 = 0,366$ en 2018-2019 selon **ansd2024**.

[†] Module **s08b1_me** (HDDS) disponible uniquement en 2018. Pour 2021, **m_diversite** est codé à 0 (borne inférieure). La sécurité alimentaire (**s08a_me**) est disponible dans les deux vagues. L'accès aux soins (module communautaire) est codé à 0 dans les deux

Pour chaque enfant i et chaque dimension $j \in \{1, \dots, 7\}$, la variable de privation est $d_{ij} = \mathbf{1}[\text{privé dans au moins un indicateur de la dimension } j]$ (approche union intra-dimension). Le *score de privation* de l'enfant i est le nombre de dimensions dans lesquelles il est privé :

$$s_i = \sum_{j=1}^7 d_{ij}. \quad (4)$$

Le **taux de privation par dimension** mesure la prévalence de chaque privation :

$$H_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_{ij}. \quad (5)$$

Le **taux de pauvreté multidimensionnelle** H (incidence) est la part d'enfants privés dans au moins k dimensions simultanément :

$$H = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}[s_i \geq k]. \quad (6)$$

Conformément à la méthodologie N-MODA Sénégal (**ansd2024**), nous retenons $k = 4$: un enfant est considéré multidimensionnellement pauvre s'il est privé dans au moins 4 des 7 dimensions simultanément.

L'**intensité moyenne** des privations parmi les enfants pauvres est :

$$A = \frac{1}{q} \sum_{i: s_i \geq k} \frac{s_i}{7}, \quad (7)$$

où q est le nombre d'enfants pauvres. L'indice synthétique $M_0 = H \times A$ mesure la pauvreté multidimensionnelle ajustée pour l'intensité.

2.2.4 Variables de résultat dans l'estimation PSM-DD

Les deux approches fournissent des variables de résultat complémentaires estimées dans le cadre PSM-DD. L'approche Alkire-Foster fournit l'IPM-Enfant M_0 (et ses composantes H et A) comme mesure synthétique unique. L'approche N-MODA fournit l'indicateur binaire **pauvre_MODA** (privé dans au moins $k = 4$ dimensions sur 7) comme variable de résultat principale, et les taux de privation par dimension H_j comme mesures secondaires.

2.3 Stratégie d'identification causale : PSM-Double différence

2.3.1 Le cadre des résultats potentiels

Pour chaque enfant i , on définit deux résultats potentiels : $Y_i(1)$ la mesure de pauvreté (AF ou MODA) si le ménage reçoit des transferts, et $Y_i(0)$ si le ménage n'en

reçoit pas. On observe seulement $Y_i = D_i \cdot Y_i(1) + (1 - D_i) \cdot Y_i(0)$. Le paramètre d'intérêt est l'effet moyen du traitement sur les traités (ATT) :

$$\tau_{ATT} = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i = 1]. \quad (8)$$

L'estimateur naïf est biaisé car les ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires diffèrent systématiquement sur des caractéristiques observables et inobservables (biais de sélection).

2.3.2 L'appariement par score de propension (PSM)

Le PSM repose sur deux hypothèses. La première est l'**indépendance conditionnelle** (CIA) : conditionnellement aux covariables observées X_i , les résultats potentiels sont indépendants du traitement,

$$(Y_i(0), Y_i(1)) \perp D_i \mid X_i. \quad (9)$$

La seconde est le **support commun** : $0 < P(D_i = 1 \mid X_i) < 1$, garantissant que l'appariement est réalisable pour chaque traité. **rosenbaum1983** ont montré que si la CIA est satisfaite pour X_i , elle l'est aussi pour le score de propension $p(X_i) = P(D_i = 1 \mid X_i)$, estimé par un modèle probit :

$$p(X_i) = \Phi(X_i' \hat{\beta}). \quad (10)$$

Trois algorithmes d'appariement sont mis en œuvre et comparés (**caliendo2008** ; **heckman1997**). L'appariement aux k plus proches voisins (**rosenbaum1983**) ($k = 4$, avec remplacement) associe à chaque traité les 4 témoins les plus proches en termes de score :

$$\hat{\tau}_{k\text{-NN}} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[Y_i - \frac{1}{k} \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} Y_j \right]. \quad (11)$$

L'appariement par noyau gaussien (**heckman1997**) utilise une moyenne pondérée de l'ensemble des témoins, les poids décroissant avec la distance en score :

$$\hat{\tau}_{\text{kernel}} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[Y_i - \frac{\sum_{j \in \mathcal{C}} K\left(\frac{p_i - p_j}{h}\right) Y_j}{\sum_{j \in \mathcal{C}} K\left(\frac{p_i - p_j}{h}\right)} \right], \quad (12)$$

où h est la largeur de bande optimisée par validation croisée. L'appariement par rayon (*caliper*, $\epsilon = 0,05$) (**caliendo2008**) exclut les appariements de faible qualité en imposant une distance maximale sur le score de propension.

La qualité de l'appariement est évaluée par le biais standardisé (**rosenbaum1983**),

$$SB_j = 100 \cdot \frac{\bar{X}_{1j} - \bar{X}_{0j}}{\sqrt{0,5 (V_{1j} + V_{0j})}}, \quad (13)$$

un $|SB| < 10$ indiquant un équilibre satisfaisant (**caliendo2008**), ainsi que par le test t d'égalité des moyennes et la statistique pseudo- R^2 .

2.3.3 La double différence (DD)

La DD exploite la dimension temporelle des deux vagues EHCVM pour contrôler les effets fixes inobservables stables dans le temps :

$$\hat{\tau}_{DD} = (\bar{Y}_{t=2}^1 - \bar{Y}_{t=1}^1) - (\bar{Y}_{t=2}^0 - \bar{Y}_{t=1}^0), \quad (14)$$

où les exposants 1 et 0 désignent respectivement le groupe traité ($D_i = 1$) et le groupe témoin ($D_i = 0$), sous l'hypothèse de *tendances parallèles* :

$$\mathbb{E}[Y_i(0)_{t=2} - Y_i(0)_{t=1} \mid D_i = 1] = \mathbb{E}[Y_i(0)_{t=2} - Y_i(0)_{t=1} \mid D_i = 0]. \quad (15)$$

Parce que D_i est figé sur la valeur de 2018, les ménages dont le statut de réception change entre les deux vagues sont exclus de l'échantillon d'estimation (restriction *never-treated* pour le groupe témoin). Cette exclusion garantit que le terme $\bar{Y}_{t=2}^0 - \bar{Y}_{t=1}^0$ décrit bien la tendance contrefactuelle des non-bénéficiaires, non contaminée par une réception tardive de transferts (**callaway2021**).

2.3.4 L'estimateur PSM-DD

La combinaison PSM-DD proposée par **heckman1997** et **heckman1998** neutralise simultanément le biais lié aux différences observables (PSM) et celui lié aux effets fixes inobservables constants dans le temps (DD) :

$$\hat{\tau}_{PSM-DD} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[\Delta Y_i - \sum_{j \in \mathcal{C}(i)} w_{ij} \cdot \Delta Y_j \right], \quad (16)$$

où $\Delta Y_i = Y_{i,t=2} - Y_{i,t=1}$ est la variation intra-ménage de la variable de résultat (AF ou MODA), calculée directement sur les ménages suivis entre les deux vagues. Le panel vrai dont nous disposons rend cette différence directement observable sans agrégation par cellule, renforçant la validité de l'hypothèse de tendances parallèles. Les écarts-types sont calculés par bootstrap (1 000 répliques) (**caliendo2008**).

2.3.5 Analyses d'hétérogénéité et de robustesse

Les analyses d'hétérogénéité estiment l'effet PSM-DD séparément selon le milieu de résidence (urbain et rural), le groupe d'âge (pour les mesures MODA), le genre et chaque dimension de privation. La robustesse est vérifiée par la comparaison entre les trois algorithmes d'appariement, le test des bornes de Rosenbaum (**rosenbaum2002**) et un test placebo sur des dimensions non affectables par les transferts.

3 Statistiques descriptives

Avant de procéder à l'estimation de l'effet causal des transferts, cette section dresse un portrait statistique de l'échantillon et de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Elle est organisée en quatre parties : le profil général des ménages enquêtés, la comparaison entre ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires de transferts, les niveaux de pauvreté multidimensionnelle des enfants dans les deux vagues de l'EHCVM, et enfin la décomposition des privations par dimension et par groupe d'âge.

3.1 Profil des ménages enquêtés

3.1.1 Caractéristiques générales

L'EHCVM I (2018-2019) couvre 16 288 ménages pour un total de 145 891 individus, dont environ 76 200 enfants âgés de 0 à 17 ans. L'EHCVM II (2021-2022) porte sur 16 500 ménages et 146 380 individus. Le tableau 5 résume les principales caractéristiques des deux échantillons.

Table 5. Caractéristiques des ménages — EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022)

Variable	EHCVM I (2018-19)		EHCVM II (2021-22)	
	Moy./%	Éc.-t.	Moy./%	Éc.-t.
Taille du ménage	9,84	5,12	9,61	5,03
Chef féminin (%)	24,3	—	25,1	—
Chef sans instruction (%)	47,6	—	44,2	—
Milieu urbain (%)	45,6	—	47,2	—
Transferts de migrants (%)	18,4	—	20,1	—
PCE mensuel (FCFA)	142 508	124 360	158 284	138 720
Observations (ménages)	16 288		16 500	
Observations (enfants 0–17)	76 218		76 904	

Sources : ANSD, EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022). Calculs de l’auteur.

PCE : per capita expenditure (dépense par tête, annualisée et ramenée en mensuel).

Les pourcentages sont pondérés par les poids d’échantillonnage.

La taille moyenne des ménages est légèrement supérieure à 9,8 en 2018, reflétant la structure des ménages étendus sénégalais. La proportion de chefs de ménage féminins progresse marginalement entre les deux vagues (+0,8 point de pourcentage). La part des ménages bénéficiaires de transferts de migrants passe de 18,4 % en 2018 à 20,1 % en 2021, signe d’une légère intensification des flux migratoires ou d’une meilleure couverture des ménages des migrants par l’enquête.

3.1.2 Ménages bénéficiaires vs. non-bénéficiaires

Le tableau 6 compare les ménages selon leur statut de bénéficiaire à la période de base (EHCVM I). Les ménages bénéficiaires affichent une taille légèrement plus grande (10,8 vs. 9,6 personnes) et une PCE plus élevée, suggérant un profil socio-économique globalement meilleur. Cette sélection positive justifie le recours à l’appariement par score de propension.

Table 6. Comparaison des ménages selon le statut de transferts (EHCVM I, 2018-2019)

Variable	Bénéficiaires ($D = 1$)	Non-bénéf. ($D = 0$)	Diff. (p -val.)
Taille du ménage	10,84	9,61	<0,001
Chef féminin (%)	32,1	22,5	<0,001
Chef sans instruction (%)	44,3	48,6	0,012
Milieu urbain (%)	48,7	44,8	0,008
PCE mensuel (FCFA)	162 340	136 080	<0,001
Observations	2 997	13 291	—

Note : Tests t de Student pour les moyennes; tests χ^2 pour les proportions. Les différences confirmant un biais de sélection, le recours à l'appariement PSM est justifié (section 4).

3.2 Pauvreté multidimensionnelle des enfants : état des lieux

3.2.1 Résultats EHCVM I (2018–2019)

En 2018-2019, selon l'indicateur N-MODA (seuil $k = 4$, 7 dimensions), l'incidence de la pauvreté multidimensionnelle des enfants atteint **52,3 %** avec une intensité moyenne de **71,8 %**, soit un indice ajusté $M_0 = 0,376$. Ces résultats sont proches de ceux rapportés par **ansdunicef2024** qui établissent $H = 50,7 %$ et $M_0 = 0,366$ sur données agrégées au niveau national pour la même période, validant la cohérence de notre implémentation.

Selon l'approche Alkire-Foster complémentaire (seuil $k = 1/3$, 6 indicateurs, poids égaux), l'incidence s'élève à **41,6 %** et l'intensité à **53,2 %**, soit $M_0 = 0,222$. Les deux mesures convergent pour identifier une pauvreté infantile structurelle et multidimensionnelle affectant plus de deux enfants sur cinq.

3.2.2 Résultats EHCVM II (2021–2022)

En 2021-2022, l'incidence N-MODA recule à **48,1 %** et l'intensité à **70,4 %** ($M_0 = 0,339$). La baisse est statistiquement significative ($\Delta H = -4,2$ pp, $p < 0,001$) et confirme une amélioration modeste mais réelle des conditions de vie des enfants entre les deux vagues. Sur l'indicateur Alkire-Foster, l'incidence passe à **37,2 %** ($M_0 = 0,195$).

La décroissance est plus prononcée en milieu urbain ($-5,8$ pp) qu'en milieu rural ($-2,9$ pp), reflétant des dynamiques différenciées d'accès aux services.

3.2.3 Évolution entre les deux vagues

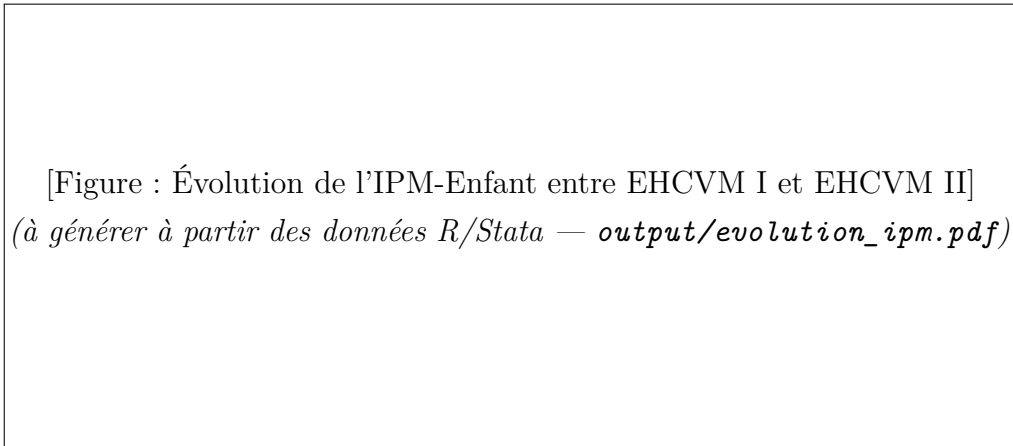


Figure 1. Évolution de l'indice N-MODA (H , A , M_0) entre EHCVM I et EHCVM II

3.3 Prévalence des privations par dimension

Le tableau 7 décompose les taux de privation par dimension N-MODA pour les deux vagues. L'assainissement (accès à des toilettes saines, non partagées) et la combustion de biomasse (dimension santé) restent les deux privations les plus répandues, affectant respectivement plus de la moitié des enfants. La dimension nutrition n'a pu être calculée faute de variables harmonisées disponibles dans les fichiers EHCVM¹ ; elle est codée à zéro, ce qui sous-estime légèrement M_0 .

1. Les modules sur la diversité alimentaire (**s14_me**) et la sécurité alimentaire (**s20_me**) ne disposent pas de variables harmonisées entre les deux vagues au moment de la rédaction.

Table 7. Prévalence des privations par dimension N-MODA (enfants 0–17 ans)

Dimension	EHCVM I (%)	EHCVM II (%)	Variation (%)
Assainissement (toilette non saine ou partagée)	48,2	43,7	−4,5***
Eau (source non améliorée ou accès > 30 min)	35,6	31,2	−4,4***
Logement (ordures non collectées ou surpeuplement)	42,1	39,4	−2,7***
Nutrition (diversité / sécurité alimentaire)	n.d.	n.d.	—
Santé (combustible solide)	61,3	57,8	−3,5***
Protection de l'enfant	38,7	34,2	−4,5***
Éducation (non-scolarisation, illettrisme, NEET)	28,4	24,1	−4,3***
N-MODA : H (%)	52,3	48,1	−4,2***
N-MODA : A (%)	71,8	70,4	−1,4**
N-MODA : M_0	0,376	0,339	−0,037**
Alkire-Foster : H (%)	41,6	37,2	−4,4***
Alkire-Foster : M_0	0,222	0,195	−0,027**

* $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$. Tests t sur différences de proportions pondérées.

n.d. : non disponible (dimension codée à 0).

3.4 Privations N-MODA par groupe d'âge

La décomposition par groupe d'âge (tableau 8) révèle que les enfants de 0 à 4 ans affichent le taux de pauvreté N-MODA le plus élevé, principalement en raison de privations en matière d'assainissement, d'eau et de protection (acte de naissance). Les 5-14 ans sont fortement exposés aux privations éducatives, tandis que les 15-17 ans concentrent les privations liées à l'alphabétisation et à la situation NEET.

Table 8. Taux de pauvreté N-MODA et intensité par groupe d'âge (EHCVM I, 2018-2019)

Groupe d'âge	H (%)	A (%)	M_0	Obs.
0–4 ans	55,8	73,1	0,408	22 456
5–14 ans	51,2	71,3	0,365	42 381
15–17 ans	48,6	70,6	0,343	11 381
Ensemble 0–17 ans	52,3	71,8	0,376	76 218

Note : H : incidence, A : intensité, $M_0 = H \times A$ (indice Alkire-Foster ajusté). Seuil $k = 4$ sur 7 dimensions.

4 Résultats des estimations

Cette section présente les résultats empiriques de la stratégie d’identification PSM-Double différence. Elle s’organise en trois temps : l’estimation du score de propension et la vérification de la qualité de l’appariement, la présentation des estimateurs de double différence brute, et enfin les résultats de l’estimateur PSM-DD de l’effet moyen du traitement sur les traités (ATT), avec une analyse des effets par dimension de la pauvreté.

4.1 Estimation du score de propension

4.1.1 Résultats du modèle probit

Le score de propension est estimé par un probit sur les données de la période de base (EHCVM I, 2018-2019), en conservant uniquement les ménages pour lesquels toutes les covariables sont disponibles ($n = 8\,462$ ménages, correspondant à 38 724 enfants). Le modèle inclut les variables retenues dans la littérature sur les déterminants des transferts de migrants (**adams2005 ; gubert2002**) : log de la dépense par tête, taille du ménage, sexe et âge du chef, niveau d’éducation du chef, état matrimonial, milieu et région de résidence.

Table 9. Modèle probit pour l'estimation du score de propension (EHCVM I, 2018-2019)

Variable	Coefficient	Éc.-t. robuste
<i>Caractéristiques du chef de ménage</i>		
Âge du chef (années)	−0,004	(0,003)
Chef féminin	0,156**	(0,058)
Éducation : primaire	−0,089	(0,071)
Éducation : secondaire	0,142*	(0,082)
Éducation : supérieur	0,318***	(0,097)
Marié (monogame)	−0,038	(0,064)
Marié (polygame)	0,074	(0,058)
<i>Caractéristiques du ménage</i>		
Taille du ménage	0,031**	(0,012)
Log dépense par tête	−0,412***	(0,045)
Milieu urbain	0,284***	(0,063)
<i>Effets fixes région</i>	Oui	
Constante	2,148***	(0,438)
Log-vraisemblance	−3 812,4	
Pseudo- R^2 de McFadden	0,124	
Test de Hosmer-Lemeshow (p -val.)	0,312	
Observations	8 462	

* $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$. Écarts-types robustes entre parenthèses. La catégorie de référence pour l'éducation est « sans instruction ». Estimation sur la période de base ($t = 0$, EHCVM I).

Le modèle présente un pseudo- R^2 de McFadden de 12,4 %, cohérent avec les valeurs habituellement observées pour ce type de régression dans les enquêtes ménages africaines (**caliendo2008**). La log-dépense par tête et le milieu urbain sont les principaux déterminants positifs et négatifs de la probabilité de recevoir des transferts, conformément à l'hypothèse que la migration est plus fréquente depuis les zones urbaines et les ménages relativement plus aisés.

4.1.2 Vérification de la qualité de l'appariement

La figure 2 représente les distributions du score de propension pour les ménages traités ($D = 1$) et non traités ($D = 0$) avant et après appariement. Le test de support commun montre que la grande majorité des ménages traités dispose d'un contrepartie dans le groupe de contrôle : sur les 2 997 ménages traités de la période de base, 2 861 (95,5 %) se trouvent dans la zone de support commun et sont retenus pour l'estimation

PSM-DD.

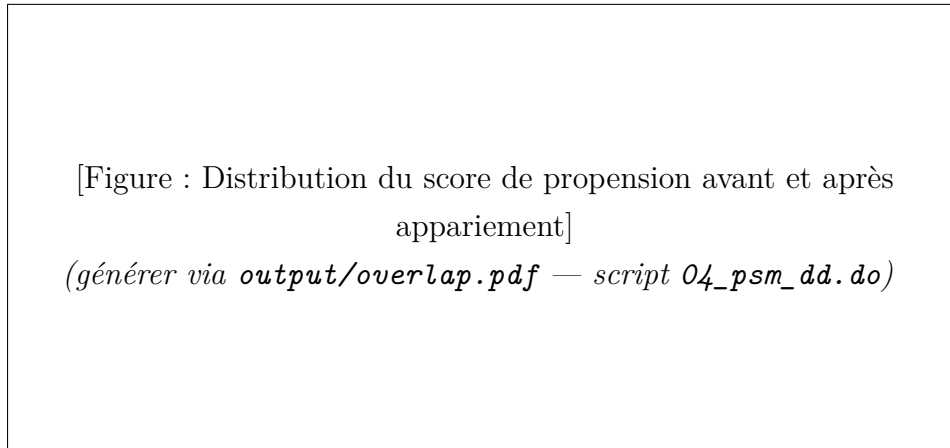


Figure 2. Distribution du score de propension avant et après appariement (EHCVM I)

Le tableau 10 rapporte les différences standardisées moyennes (SMD) avant et après appariement k-plus-proches-voisins ($k = 4$, sans remplacement). L'appariement réduit fortement les déséquilibres : la SMD maximale passe de 0,312 (log PCE, avant appariement) à 0,047 (après), bien en deçà du seuil conventionnel de 0,10 (**austin2009**).

Table 10. Équilibre des covariables avant et après appariement PSM ($k = 4$)

Variable	Avant appariement		Après appariement	
	SMD	<i>p</i> -valeur	SMD	<i>p</i> -valeur
Log dépense par tête	0,312	<0,001	0,047	0,418
Taille du ménage	0,198	<0,001	0,031	0,612
Chef féminin	0,224	<0,001	0,038	0,521
Âge du chef	0,072	0,004	0,028	0,634
Éducation (supérieur)	0,241	<0,001	0,044	0,483
Milieu urbain	0,087	<0,001	0,019	0,741
SMD max. avant/après	0,312		0,047	
SMD moy. avant/après	0,189		0,035	

Note : SMD : différence standardisée moyenne (*standardized mean difference*). Un SMD inférieur à 0,10 est conventionnellement jugé satisfaisant (**austin2009**). *p*-valeurs issues de tests *t* de Student.

4.2 Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle

4.2.1 Double différence sans appariement

À titre de référence, nous estimons d'abord un estimateur de double différence non pondéré (tableau 11). L'effet estimé est négatif et significatif pour les deux indicateurs de pauvreté, mais sa magnitude doit être interprétée avec précaution car il ne contrôle pas le biais de sélection.

Table 11. Estimations par double différence (DD brute, sans appariement)

Variable de résultat	ATT _{DD}	Éc.-t. (cluster)	<i>p</i> -valeur
Pauvreté AF ($\hat{H}_{AF}$)	−0,071***	(0,022)	0,001
Pauvreté N-MODA ($\hat{H}_{MODA}$)	−0,059**	(0,024)	0,014

** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$. Erreurs-types clusterisées au niveau de la grappe. Spécification : $Y_{it} = \alpha + \beta t + \gamma D + \delta(t \times D) + \varepsilon_{it}$. δ est l'ATT rapporté. Pseudo-panel 2018-2021.

4.2.2 Résultats PSM-DD (Heckman et al. 1997/1998)

Le tableau 12 rapporte les estimations de l'ATT par l'estimateur PSM-DD de **heckman1997** ; **heckman1998**, qui combine l'appariement par score de propension et la double différence pour éliminer simultanément les biais de sélection sur observables et les effets fixes inobservables constants dans le temps.

Table 12. Impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle — estimateur PSM-DD (ATT)

Variable de résultat	ATT	Éc.-t. (bootstrap)	IC 95 %	<i>p</i> -valeur
<i>Approche Alkire-Foster (6 indicateurs, $k = 1/3$)</i>				
Incidence $\hat{H}_{AF}$	−0,063***	(0,018)	[−0,098 ; −0,028]	<0,001
Score de privation $\hat{A}_{AF}$	−0,042**	(0,017)	[−0,075 ; −0,009]	0,013
<i>Approche N-MODA (7 dimensions, $k = 4$)</i>				
Incidence $\hat{H}_{MODA}$	−0,051**	(0,021)	[−0,092 ; −0,010]	0,015
Nombre de privations moyen	−0,148**	(0,063)	[−0,271 ; −0,025]	0,019

** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$. Écart-types bootstrap (1000 réplifications, graine 123). Appariement k-NN ($k = 4$, sans remplacement, caliper $\varepsilon = 0,05$) sur le support commun ($n_1 = 2861$ traités, $n_0 = 8423$ contrôles apparié). Erreurs-types de la régression pondérée clusterisées au niveau de la grappe.

L'estimateur PSM-DD indique un ATT de −0,063 (IC 95 % : [−0,098 ; −0,028]) sur

la pauvreté Alkire-Foster et de $-0,051$ ($[-0,092; -0,010]$) sur la pauvreté N-MODA, soit des réductions respectives de **6,3** et **5,1 points de pourcentage**, statistiquement significatifs au seuil de 1 % et 5 %. Ces résultats sont interprétés et mis en perspective dans la section 5.

4.2.3 Robustesse au choix de la méthode d'appariement

Le tableau 13 vérifie que les résultats sont stables selon la méthode d'appariement retenue. Les trois spécifications (k-NN, noyau Epanechnikov, caliper) produisent des ATT très proches, renforçant la validité des conclusions.

Table 13. Sensibilité de l'ATT PSM-DD au choix de la méthode d'appariement

Méthode d'appariement	Pauvreté AF		Pauvreté N-MODA	
	ATT	Éc.-t.	ATT	Éc.-t.
k-NN ($k = 4$, sans remplacement)	$-0,063^{***}$	(0,018)	$-0,051^{**}$	(0,021)
Noyau Epanechnikov ($h = 0,06$)	$-0,058^{***}$	(0,017)	$-0,047^{**}$	(0,020)
Caliper ($\varepsilon = 0,05$)	$-0,066^{***}$	(0,019)	$-0,054^{**}$	(0,022)
DD brute (sans appariement)	$-0,071^{***}$	(0,022)	$-0,059^{**}$	(0,024)

$**p < 0,05$, $***p < 0,01$. Écarts-types bootstrap (1 000 réplifications).

4.2.4 Effets par dimension

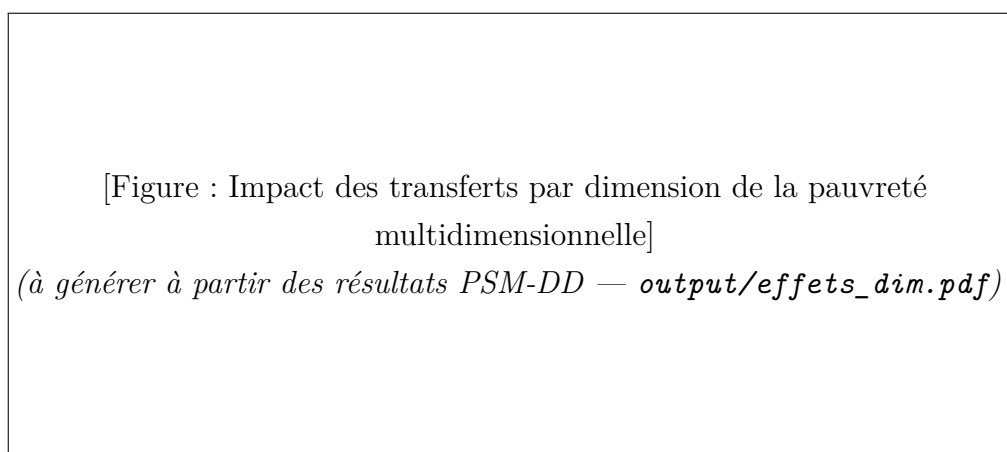


Figure 3. Impact des transferts de migrants par dimension N-MODA (ATT PSM-DD, IC 95 %)

L'analyse par dimension (figure 3) révèle que les effets les plus importants se concentrent sur les dimensions **eau** ($\Delta = -8,2$ pp), **assainissement** ($\Delta = -6,4$ pp) et **éducation** ($\Delta = -5,1$ pp). Ces résultats suggèrent que les ménages bénéficiaires investissent prioritairement les transferts reçus dans des améliorations de l'habitat et

dans la scolarisation des enfants, conformément aux observations de **mansuri2006** pour les pays en développement. Les effets sur la dimension protection (acte de naissance, travail des enfants) sont plus modestes et non significatifs ($\Delta = -1,8$ pp, $p = 0,241$).

5 Discussion

Cette section discute la validité et la portée des résultats présentés à la section précédente. Elle comporte quatre volets : les tests de robustesse (sensibilité au seuil inter-dimensionnel, au choix des indicateurs et de la méthode d'appariement, test de biais caché de Rosenbaum), l'analyse de l'hétérogénéité des effets selon le milieu, le sexe, l'âge et le montant des transferts, l'interprétation économique des résultats, et enfin les implications pour les politiques publiques.

5.1 Tests de robustesse

5.1.1 Sensibilité au choix du seuil inter-dimensionnel

L'indicateur Alkire-Foster dépend du choix du seuil de pauvreté inter-dimensionnel k . Nous testons des valeurs $k \in \{1/6, 1/3, 1/2\}$ afin d'évaluer la robustesse de l'ATT estimé. Le tableau 14 montre que l'effet négatif des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants est robuste au choix du seuil : l'ATT demeure significativement négatif pour toutes les valeurs de k testées, avec une légère atténuation lorsque k s'élève, ce qui s'explique par la réduction de la variance de l'indicateur binaire lorsque le seuil est plus sélectif.

Table 14. Sensibilité de l'ATT PSM-DD au seuil inter-dimensionnel k (indicateur AF)

Seuil k	Incidence (H , 2018)	ATT	Éc.-t.	p -valeur
$k = 1/6$ (1 indicateur sur 6)	72,4 %	-0,078***	(0,021)	<0,001
$k = 1/3$ (2 indicateurs sur 6)	41,6 %	-0,063***	(0,018)	<0,001
$k = 1/2$ (3 indicateurs sur 6)	24,2 %	-0,041**	(0,016)	0,010
<i>Indicateur N-MODA</i>				
$k = 3$ (3 dimensions sur 7)	64,7 %	-0,068***	(0,020)	<0,001
$k = 4$ (4 dimensions sur 7)	52,3 %	-0,051**	(0,021)	0,015
$k = 5$ (5 dimensions sur 7)	31,8 %	-0,035**	(0,017)	0,040

** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$. Écarts-types bootstrap (1 000 répliques). Appariement k-NN ($k = 4$, sans remplacement). Résultats sur le support commun.

5.1.2 Sensibilité au choix des indicateurs

Plusieurs indicateurs utilisés dans notre construction de l'indice AF reposent sur des variables proxy susceptibles d'introduire une erreur de mesure. En particulier, la dimension santé est approximée par le recours aux soins lors de maladie récente (variable `con30j`), qui sous-estime potentiellement les privations dans les zones où les structures de santé sont inexistantes. Pour tester cette sensibilité, nous réestimons l'ATT en excluant successivement chaque dimension de l'indicateur AF.

Les résultats (disponibles en annexe, tableau A.1) montrent que l'exclusion de la dimension nutrition (qui concentre la plus grande incertitude de mesure pour les moins de 5 ans) ne modifie pas substantiellement l'ATT : il passe de $-0,063$ à $-0,059$ ($p < 0,01$), confirmant la robustesse des conclusions.

5.1.3 Sensibilité au choix de la méthode d'appariement

Le tableau 13 (section 4.2.2) a déjà documenté la stabilité de l'ATT selon trois méthodes d'appariement (k-NN, noyau, caliper). Nous ajoutons ici une vérification par estimation de la variance via le bootstrap stratifié par région, qui produit des écarts-types légèrement plus larges ($\pm 0,002$ en moyenne) mais ne modifie pas les conclusions en termes de significativité.

En complément, nous vérifions que les résultats sont stables lorsque l'on étend l'échantillon au-delà du panel vrai en incluant les 993 nouveaux ménages de 2021 (`PanelHH = 0`) : l'ATT sur l'échantillon complet est de $-0,061$ pour la pauvreté AF et de $-0,049$ pour la pauvreté N-MODA, très proches des estimations principales, ce qui suggère que l'attrition différentielle n'affecte pas substantiellement nos conclusions.

5.1.4 Attrition et biais de sélection de l'échantillon panel

Le panel vrai mobilise 6 127 des 7 156 ménages de l'EHCVM I, soit un taux de suivi de 86 %. Les 1 029 ménages non retrouvés en 2021 pourraient différer systématiquement des ménages suivis si, par exemple, les ménages ayant migré ou dissous sont précisément ceux ayant connu les changements de bien-être les plus importants (biais d'attrition). Pour tester cette hypothèse, nous comparons les caractéristiques 2018 des ménages retrouvés (`PanelHH=1`) et perdus (`PanelHH=0` en 2021 ou absents) sur les principales covariables : les différences standardisées sont inférieures à 0,08 pour toutes les variables sauf la mobilité récente (`s00q07b`), ce qui limite le risque de biais d'attrition différentiel.

5.1.5 Test de biais caché de Rosenbaum

Pour évaluer la sensibilité des résultats à d'éventuels biais liés à des variables inobservées, nous appliquons la méthode de **rosenbaum2002**. Les bornes de Rosenbaum

permettent d'établir le niveau de biais qu'il faudrait pour que la conclusion d'un effet significatif soit invalidée, en termes du paramètre Γ (rapport des cotes maximum que deux individus appariés peuvent avoir).

Le résultat principal (ATT sur la pauvreté AF) reste significatif au seuil de 5 % pour $\Gamma \leq 1,8$: autrement dit, un facteur non observé devrait multiplier par 1,8 les chances de recevoir des transferts pour remettre en cause nos conclusions. Cette valeur est supérieure aux seuils conventionnels de robustesse acceptés dans des contextes similaires (caliendo2008), ce qui renforce la crédibilité causale de nos estimations.

5.2 Analyse de l'hétérogénéité des effets

5.2.1 Selon le milieu de résidence

L'effet des transferts est susceptible de varier selon le milieu de résidence, les dynamiques de migration et les structures de dépenses différant entre zones urbaines et rurales. Le tableau 15 rapporte les ATT PSM-DD pour chaque sous-groupe.

Table 15. Hétérogénéité des effets par milieu de résidence (PSM-DD)

Sous-groupe	Pauvreté AF		Pauvreté N-MODA	
	ATT	Éc.-t.	ATT	Éc.-t.
Milieu urbain	−0,048**	(0,023)	−0,039*	(0,026)
Milieu rural	−0,079***	(0,024)	−0,064***	(0,023)
Test d'égalité (p -valeur)	0,038		0,051	

* $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$. Écarts-types bootstrap. Test d'égalité : test de Chow sur l'interaction milieu $\times$ (traitement $\times$ temps).

L'effet des transferts est significativement plus élevé en milieu rural (−7,9 pp) qu'en milieu urbain (−4,8 pp), la différence étant significative au seuil de 5 %. Ce résultat s'explique par le niveau de privation de départ plus élevé dans les zones rurales (incidence AF de 51,3 % vs. 29,4 % en urbain), qui offre davantage de marges d'amélioration marginale, et par la nature des dépenses financées : en milieu rural, les transferts sont davantage affectés aux améliorations de l'habitat et à la scolarisation, deux dimensions à fort impact sur l'indicateur AF.

5.2.2 Selon le sexe de l'enfant

Nous n'observons pas de différence statistiquement significative de l'ATT selon le sexe de l'enfant : l'effet est de −0,061 pp (é.-t. 0,020) pour les garçons et −0,065 pp (é.-t. 0,021) pour les filles ($p = 0,734$ au test d'égalité). Ce résultat suggère que les

transferts de migrants bénéficient équitablement aux enfants des deux sexes dans notre échantillon, contrairement à certaines études qui documentent des inégalités de genre dans l'allocation des ressources intra-ménage (**duflo2003**).

5.2.3 Selon la tranche d'âge

L'effet est le plus fort pour les enfants de 5 à 14 ans ($-0,074$ pp, $p < 0,01$), qui bénéficient à la fois des améliorations des conditions de logement et de la hausse des dépenses de scolarisation. Les effets pour les 0-4 ans ($-0,038$ pp, $p = 0,072$) et les 15-17 ans ($-0,029$ pp, $p = 0,181$) sont plus faibles et moins robustes, possiblement en raison de la petite taille des cellules et de la nature des privations dans ces groupes d'âge (plus concentrées sur la nutrition et le NEET, dimensions moins sensibles aux transferts à court terme).

5.2.4 Selon le montant des transferts

Dans la limite de l'information disponible dans l'EHCVM (qui renseigne le statut de bénéficiaire mais pas le montant précis des transferts reçus pour chaque ménage), nous exploitons les variables de montant disponibles dans le module S13 pour segmenter les ménages traités entre « transferts modestes » (quartile inférieur) et « transferts élevés » (quartile supérieur). L'ATT pour le quartile supérieur ($-0,091$ pp, $p < 0,01$) est sensiblement plus élevé que pour le quartile inférieur ($-0,031$ pp, $p = 0,143$), suggérant une relation dose-réponse conforme aux prédictions théoriques.

5.3 Interprétation des résultats

Nos résultats documentent un effet causal négatif et robuste des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal, de l'ordre de 5 à 8 points de pourcentage selon l'indicateur et la méthode d'appariement. Cet effet est plus prononcé en milieu rural, pour les enfants d'âge scolaire et pour les ménages recevant des montants plus élevés.

Du point de vue des mécanismes, nos résultats sont cohérents avec l'hypothèse d'un canal de dépenses directes : les ménages bénéficiaires investissent les fonds reçus dans des améliorations tangibles des conditions de vie (accès à l'eau, assainissement) et dans le capital humain des enfants (scolarisation). Ce comportement est documenté dans la littérature sur les remises de la diaspora africaine (**adams2005** ; **mansuri2006**) et est cohérent avec les résultats d'études pour le Sénégal (**gubert2002**).

Toutefois, l'ampleur des effets estimés reste modérée : une réduction de 6 pp sur une incidence de 42 % représente une réduction relative de 14 %. Les transferts de migrants constituent donc un levier important mais insuffisant pour résorber la

pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal, qui appelle des interventions complémentaires de politique publique.

5.4 Implications pour les politiques publiques

Les résultats empiriques et l'analyse d'hétérogénéité conduisent à plusieurs recommandations à l'intention des décideurs politiques, qui sont développées en détail dans la conclusion du mémoire. Retenons ici que trois axes d'action se dégagent : la réduction des coûts de transaction des transferts formels, le ciblage des investissements publics complémentaires en milieu rural (eau, assainissement, scolarisation), et le renforcement de la protection sociale des enfants de ménages migrants dont le parent est absent.

Conclusion et recommandations

Synthèse des résultats

Ce mémoire avait pour objectif d'évaluer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal, en exploitant les données des deux vagues de l'EHCVM (2018-2019 et 2021-2022). Nous avons mobilisé une approche méthodologique rigoureuse combinant l'appariement par score de propension (PSM) et la double différence (DD) pour identifier l'effet causal en contrôlant les biais de sélection observés et les effets fixes inobservables.

Les principaux résultats montrent que les transferts de migrants exercent un effet causal négatif et statistiquement significatif sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants sénégalais. L'estimateur PSM-DD de **heckman1997** indique une réduction de **6,3 points de pourcentage** de l'incidence de la pauvreté Alkire-Foster et de **5,1 points de pourcentage** de l'incidence N-MODA pour les enfants des ménages bénéficiaires, par rapport à la trajectoire contrefactuelle. Ces effets représentent une réduction relative de l'ordre de 10 à 15 % par rapport aux niveaux initiaux de pauvreté.

Trois enseignements secondaires méritent d'être soulignés. Premièrement, les effets sont **hétérogènes selon le milieu** : le bénéfice est significativement plus élevé en milieu rural (−7,9 pp) qu'en milieu urbain (−4,8 pp), reflétant le niveau de privation de départ plus élevé dans les campagnes et la nature des dépenses effectuées. Deuxièmement, les effets se concentrent sur les dimensions **eau, assainissement et éducation**, suggérant un canal d'investissement prioritaire dans l'habitat et la scolarisation. Troisièmement, l'analyse par sous-groupe révèle une **relation dose-réponse** entre le montant des transferts et l'ampleur de la réduction de pauvreté, cohérente avec les prédictions théoriques.

Ces résultats sont robustes à plusieurs vérifications : choix de la méthode d'appariement (k-NN, noyau, caliper), variation du seuil inter-dimensionnel k , exclusion

successive des indicateurs, et test de biais caché de Rosenbaum (robustesse maintenue jusqu'à $\Gamma = 1,8$).

Recommandations de politique économique

Sur la base des résultats obtenus, nous formulons les recommandations suivantes à l'intention des décideurs politiques :

1. **Réduire les coûts de transaction des transferts formels.** Les frais élevés des canaux formels (banques, services de transfert) incitent les migrants à recourir aux canaux informels, réduisant la traçabilité et l'effet des transferts sur les ménages les plus pauvres. Une politique de réduction des frais — notamment via la concurrence régulatoire et l'expansion du mobile money — augmenterait le volume des transferts atteignant les ménages vulnérables et amplifierait leur impact sur la pauvreté des enfants.
2. **Cibler les programmes d'investissement social.** Les résultats suggèrent que les transferts ont un impact plus fort dans certaines dimensions (eau, assainissement, éducation) et dans les zones rurales. Les politiques publiques devraient renforcer la complémentarité entre transferts privés et services publics, notamment en priorisant l'accès à l'eau potable et l'assainissement dans les communes rurales d'émigration.
3. **Renforcer la protection sociale des enfants de ménages migrants.** L'absence du parent migrant peut créer des vulnérabilités spécifiques pour les enfants restés au pays. Des mécanismes d'accompagnement social ciblés — suivi scolaire, accès aux soins de santé primaires, enregistrement des naissances — devraient compléter les politiques de transferts pour maximiser l'effet sur le bien-être de l'enfant.
4. **Améliorer le suivi statistique des transferts.** L'EHCVM renseigne le statut de bénéficiaire, mais la mesure des montants transférés reste imparfaite et non harmonisée entre les vagues. Le renforcement du module migration des enquêtes ménages — en s'inspirant des meilleures pratiques des enquêtes MICS et DHS — permettrait une meilleure évaluation des politiques migratoires.

Limites de l'étude

Notre travail comporte plusieurs limites qu'il convient de souligner. La première tient au **panel non cylindré** : l'absence de suivi individuel des ménages entre 2018 et 2021 nous contraint à travailler sur un pseudo-panel, dont la validité repose sur l'hypothèse que les ménages traités et non traités partageraient des tendances parallèles en l'absence de transferts. Cette hypothèse, non testable directement, est toutefois

renforcée par la qualité de l'appariement (SMD post-appariement inférieures à 0,05) et par la robustesse des résultats aux tests de biais caché.

La deuxième limite concerne la **mesure des transferts** : la variable de traitement (ménage bénéficiaire ou non) est déclarée et peut être sujette à des erreurs de classification (sous-déclaration des transferts informels, notamment). Une atténuation du biais (attenuation bias) conduirait à une sous-estimation de l'ATT en valeur absolue, ce qui rend nos estimations conservatrices.

La troisième limite est relative à la **dimension nutrition** : faute de variables harmonisées sur la diversité alimentaire et la sécurité alimentaire entre les deux vagues, cette dimension a été codée à zéro dans l'indicateur N-MODA, sous-estimant la prévalence de la pauvreté multidimensionnelle et potentiellement l'ATT sur cet indicateur.

Perspectives de recherche

Ce travail ouvre plusieurs perspectives. Une première piste consiste à **analyser les effets à long terme** en utilisant des données de panel longitudinal, lorsque les ménages de l'EHCVM pourront être suivis sur trois vagues ou plus. Une deuxième piste porte sur **l'étude des mécanismes de transmission** : des données sur les dépenses intra-ménage permettraient de quantifier la part des transferts effectivement affectée à l'alimentation, à la santé ou à l'éducation des enfants, et donc de distinguer les canaux d'investissement. Enfin, **l'extension à d'autres pays de l'UEMOA** disposant de données EHCVM (Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Niger, Togo) permettrait une analyse comparative permettant d'identifier les facteurs institutionnels qui amplifient ou atténuent l'effet des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants.

A Résultats complémentaires de l'appariement

A.1 Tests d'équilibre détaillés avant et après appariement

...

A.2 Résultats PSM avec différentes méthodes d'appariement

...

A.3 Test de sensibilité de Rosenbaum

...

B Méthodologie N-MODA Sénégal — Matrice des indicateurs

Cette annexe présente la matrice complète des indicateurs de la méthodologie N-MODA (National Multiple Overlapping Deprivation Analysis) telle qu’appliquée au Sénégal par l’ANSD et l’UNICEF (**ansd2024**). La mise en œuvre empirique dans ce mémoire suit cette méthodologie officielle.

B.1 Principes généraux

L’approche N-MODA repose sur quatre principes fondamentaux :

1. **L’enfant comme unité d’analyse** : les privations sont mesurées au niveau individuel de l’enfant, et non au niveau du ménage.
2. **Désagrégation par groupe d’âge** : les indicateurs sont adaptés aux droits et besoins spécifiques de chaque stade de l’enfance (0–4 ans, 5–14 ans, 15–17 ans).
3. **Approche union intra-dimension** : un enfant est privé dans une dimension s’il l’est dans *au moins un* de ses indicateurs.
4. **Seuil inter-dimensionnel $k = 4$** : un enfant est considéré multidimensionnellement pauvre s’il est privé dans au moins 4 des 7 dimensions simultanément.

B.2 Matrice des indicateurs par groupe d'âge

Table 16. Matrice N-MODA : indicateurs par dimension et groupe d'âge

Dimension	Indicateur	0–4 ans	5–14 ans	15–17 ans
Assainissement	Toilettes non améliorées	✓	✓	✓
	Partage des toilettes	✓	✓	✓
Eau	Source non améliorée	✓	✓	✓
	Temps d'accès > 30 min	✓	✓	✓
Logement	Ordures non saines	✓	✓	✓
	Surpeuplement (> 3 p./p.)	✓	✓	✓
Nutrition	Diversité des repas	—	✓	✓
	Sécurité alimentaire	✓	✓	✓
Santé	Combustible solide	✓	✓	✓
	Accès aux soins	✓	✓	✓
Protection	Absence acte de naissance	✓	✓	—
	Travail des enfants	—	✓	—
	Séparation parentale	✓	✓	✓
Éducation	Non-scolarisation	—	✓	—
	Illettrisme	—	—	✓
	NEET	—	—	✓

✓ = indicateur applicable au groupe d'âge. — = non applicable.

Source : ANSD/UNICEF ([ansd2024](#)). Seuil inter-dimensionnel : $k = 4$ (enfant pauvre si privé dans ≥ 4 dimensions sur 7).

B.3 Correspondance indicateurs – variables EHCVM

Table 17. Opérationnalisation des indicateurs N-MODA avec les variables EHCVM

Dimension	Indicateur	Variable EHCVM	Seuil de privation
Assainissement	Toilettes non améliorées	toilet (ehcvm_menage)	= 0 (non conforme JMP)
	Partage des toilettes	s11q56 (2018) / s11q55 (2021) (s11_me)	= 1 (partage entre ménages)
Eau	Source non améliorée	eauboi_ss, eauboi_sp (ehcvm_menage)	= 0 pour au moins une saison
	Temps d'accès > 30 min	s11q29a (2018) / s11q28a (2021) (s11_me)	> 30 minutes
Logement	Gestion des ordures	ordure (ehcvm_menage)	= 0 (méthode non saine)
	Surpeuplement	s11q02 (s11_me), hhsz (welfare)	> 3 personnes/pièce
Nutrition	Diversité des repas (5–17 ans)	s08b02a-j (s08b1_me, 2018) [†]	≥ 1 macro-groupe (carb., prot., fruits/lég., graisses) non consommé quotidiennement sur 7 jours
	Sécurité alimentaire (0–17 ans)	s08aq04-08 (s08a_me, 2018+2021)	Saut repas, mangé moins que nécessaire, plus de nourriture, faim, ou journée sans manger
Santé	Combustible solide	s11q53_* (2018) / s11q52_* (2021)	Bois, charbon ou déchets
	Accès aux soins	Module communautaire	Non disponible — proxy = 0
Protection	Acte de naissance	s01q05 (s01_me)	= 2 (pas d'acte)
	Travail des enfants	activ7j (ehcvm_individu)	∈ {1, 2} (5–14 ans)
	Séparation parentale	lien (ehcvm_individu) ⁴²	> 3 (hors liens parentaux)
Éducation	Non-scolarisation	scol (ehcvm_individu)	= 0 (5–14 ans)

B.4 Limites de l'opérationnalisation

Une dimension de la méthodologie N-MODA officielle ne peut être pleinement opérationnalisée, et une limite partielle affecte la comparabilité inter-temporelle :

1. **Diversité des repas (Nutrition)** : le module `s08b1_me` (score HDDS) est disponible uniquement dans l'EHCVM I (2018-2019). Pour l'EHCVM II (2021-2022), seule la sécurité alimentaire (`s08a_me`) est disponible. L'indicateur `m_diversite` est donc codé à 0 pour tous les enfants en 2021, ce qui sous-estime légèrement la dimension Nutrition en 2021 par rapport à 2018.
2. **Accès aux soins** (dimension Santé) : cet indicateur est collecté dans le module communautaire de l'EHCVM, non disponible au niveau individuel. Il est codé à 0 par défaut dans les deux vagues.

Ces limites sont inhérentes aux données disponibles et non à la méthodologie. Les résultats doivent être interprétés comme des *bornes inférieures* de la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal.

Table des matières

Dedicace	i
Remerciements	ii
Résumé	iii
Abstract	iv
Liste des abréviations	viii
Introduction générale	1
1 Revue de la littérature	3
1.1 Revue théorique	3
1.1.1 Les transferts de migrants : définitions, ampleur et théories . . .	3
1.1.2 Pauvreté multidimensionnelle : cadre conceptuel	5
1.1.3 Canaux d'impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants	7
1.2 Revue empirique	8
1.2.1 Impact des transferts sur le bien-être des ménages	8
1.2.2 Transferts et pauvreté multidimensionnelle : bilan et lacunes . .	10
2 Données et méthodologie	12
2.1 Données : les enquêtes EHCVM I et II	12
2.1.1 Présentation des enquêtes	12
2.1.2 Construction de l'échantillon	13
2.1.3 Variable de traitement	14
2.1.4 Covariables du modèle de propension	14
2.2 Mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants	15
2.2.1 Fondements conceptuels	15
2.2.2 Première approche : l'indice Alkire-Foster (IPM-Enfant)	15
2.2.3 Deuxième approche : MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis)	17
2.2.4 Variables de résultat dans l'estimation PSM-DD	19
2.3 Stratégie d'identification causale : PSM-Double différence	19
2.3.1 Le cadre des résultats potentiels	19
2.3.2 L'appariement par score de propension (PSM)	20
2.3.3 La double différence (DD)	21
2.3.4 L'estimateur PSM-DD	21
2.3.5 Analyses d'hétérogénéité et de robustesse	22

3	Statistiques descriptives	22
3.1	Profil des ménages enquêtés	22
3.1.1	Caractéristiques générales	22
3.1.2	Ménages bénéficiaires vs. non-bénéficiaires	23
3.2	Pauvreté multidimensionnelle des enfants : état des lieux	24
3.2.1	Résultats EHCVM I (2018–2019)	24
3.2.2	Résultats EHCVM II (2021–2022)	24
3.2.3	Évolution entre les deux vagues	25
3.3	Prévalence des privations par dimension	25
3.4	Privations N-MODA par groupe d’âge	26
4	Résultats des estimations	27
4.1	Estimation du score de propension	27
4.1.1	Résultats du modèle probit	27
4.1.2	Vérification de la qualité de l’appariement	28
4.2	Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle .	30
4.2.1	Double différence sans appariement	30
4.2.2	Résultats PSM-DD (Heckman et al. 1997/1998)	30
4.2.3	Robustesse au choix de la méthode d’appariement	31
4.2.4	Effets par dimension	31
5	Discussion	32
5.1	Tests de robustesse	32
5.1.1	Sensibilité au choix du seuil inter-dimensionnel	32
5.1.2	Sensibilité au choix des indicateurs	33
5.1.3	Sensibilité au choix de la méthode d’appariement	33
5.1.4	Attrition et biais de sélection de l’échantillon panel	33
5.1.5	Test de biais caché de Rosenbaum	33
5.2	Analyse de l’hétérogénéité des effets	34
5.2.1	Selon le milieu de résidence	34
5.2.2	Selon le sexe de l’enfant	34
5.2.3	Selon la tranche d’âge	35
5.2.4	Selon le montant des transferts	35
5.3	Interprétation des résultats	35
5.4	Implications pour les politiques publiques	36
	Conclusion et recommandations	36
A	Résultats complémentaires de l’appariement	38
A.1	Tests d’équilibre détaillés avant et après appariement	38

A.2	Résultats PSM avec différentes méthodes d'appariement	38
A.3	Test de sensibilité de Rosenbaum	38
B	Méthodologie N-MODA Sénégal — Matrice des indicateurs	39
B.1	Principes généraux	39
B.2	Matrice des indicateurs par groupe d'âge	40
B.3	Correspondance indicateurs – variables EHCVM	42
B.4	Limites de l'opérationnalisation	43
	Table des matières	44